

MERDEKA DARI STUNTING

**OPTIMALISASI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BERBASIS
PANGAN LOKAL, COOKING CLASS DAN PELATIHAN KADER
TERHADAP PENINGKATAN KESEHATAN DAN KEBUGARAN BALITA**

**Intan Azkia Paramitha • Ratna Arifiana
Sandi Ari Susiatmi**



**MERDEKA DARI STUNTING:
OPTIMALISASI PEMBERIAN
MAKANAN TAMBAHAN BERBASIS
PANGAN LOKAL, COOKING CLASS
DAN PELATIHAN KADER
TERHADAP PENINGKATAN
KESEHATAN DAN KEBUGARAN
BALITA**

Penulis:

Bdn. Intan Azkia Paramitha, S.Tr.Keb., M.Keb.

Ratna Arifiana, SST., M.K.M.

Bdn. Sandi Ari Susiatmi, SST., M.Keb.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Merdeka Dari Stunting: Optimalisasi Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal, Cooking Class Dan Pelatihan Kader Terhadap Peningkatan Kesehatan Dan Kebugaran Balita

Penulis: Bdn. Intan Azkia Paramitha, S.Tr.Keb., M.Keb.
Ratna Arifiana, SST., M.K.M.
Bdn. Sandi Ari Susiatmi, SST., M.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Muhammad Ilham S.Pd.

ISBN: 978-634-7097-92-7

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Merdeka dari stunting : optimalisasi pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, cooking class dan pelatihan kader terhadap peningkatan kesehatan dan kebugaran balita / Bdn. Intan Azkia Paramitha, S.Tr.Keb., M.Keb., Ratna Arifiana, S.S.T., M.K.M., Bdn. Sandi Ari Susiatmi, S.S.T., M.Keb.

EDISI
PUBLIKASI
DESKRIPSI FISIK
IDENTIFIKASI
SUBJEK
KLASIFIKASI
PERPUSNAS ID

Cetakan pertama, Februari 2025
Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025.
95 halaman ; ilustrasi ; 30 cm
ISBN 978-634-7097-92-7
Gizi anak -- Kesehatan anak, Pelayanan
649.3 [23]

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1186140>

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan-Nya sehingga buku monograf berjudul ***"Merdeka dari Stunting: Optimalisasi Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal, Cooking Class, dan Pelatihan Kader terhadap Peningkatan Kesehatan dan Kebugaran Balita"*** ini dapat diselesaikan.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk mendukung program nasional dalam menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Stunting, sebagai masalah kesehatan yang memengaruhi tumbuh kembang anak, memerlukan solusi komprehensif berbasis pendekatan lokal. Buku ini menawarkan inovasi melalui pemanfaatan pangan lokal yang kaya gizi, kegiatan edukatif berupa *cooking class*, serta pemberdayaan kader posyandu sebagai agen perubahan di masyarakat.

Kami berharap, monograf ini dapat menjadi referensi bagi tenaga kesehatan, pengambil kebijakan, serta masyarakat umum dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh. Penyusunan buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi masa depan bangsa.

(Desember, 2024)

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 Pendahuluan1

BAB 2 PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN

BERBASIS PANGAN LOKAL PADA BALITA.....9

A. Pengertian Makanan Tambahan.....	9
B. Tujuan dan Syarat Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	10
1. Tujuan.....	10
2. Syarat.....	11
C. Jenis dan Kandungan Gizi Makanan Tambahan	12
1. Karbohidrat	12
2. Protein.....	13
3. Lemak	14
4. Vitamin.....	15
5. Mineral	16
D. Pangan Lokal sebagai Makanan Tambahan	19
1. Prinsip dan Persyaratan Makanan Tambahan Lokal.....	22
2. Persyaratan Makanan Tambahan Lokal.....	23
3. Cara Pengolahan PMT Lokal.....	25
4. Contoh dan Porsi PMT Lokal	27

BAB 3 *COOKING CLASS*..... 29

A. Definisi dan Tujuan Cooking Class.....	29
---	----

B. <i>Persiapan Cooking Class</i>	32
C. Perencanaan dan Pelaksanaan <i>Cooking Class</i>	35
D. Peran <i>Cooking Class</i> dalam Mencegah Stunting	41

BAB 4 PELATIHAN KADER ANTI STUNTING

(PAKEANTING)	45
A. Pendahuluan.....	45
B. Pemberdayaan kader posyandu	47
C. Pelatihan Kader Anti Stunting.....	56

BAB 5 PENUTUP..... **69**

DAFTAR PUSTAKA..... **81**

GLOSARIUM **83**

PROFIL PENULIS **85**

BAB 1

Pendahuluan

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang mendesak di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), stunting diartikan sebagai gangguan pertumbuhan kronis pada anak akibat kekurangan gizi yang berlangsung lama, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai selama periode pertumbuhan. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki tinggi badan lebih rendah dibandingkan standar usianya, serta berisiko menghadapi hambatan perkembangan kognitif, motorik, dan kesehatan jangka panjang. Di Indonesia, prevalensi stunting masih menjadi isu yang memprihatinkan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya.

Menurut Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4%, meskipun terjadi penurunan dari angka sebelumnya yang lebih tinggi. Namun, angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yaitu menurunkan prevalensi stunting menjadi 14%. Masalah ini menjadi tantangan besar karena stunting tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi bangsa secara keseluruhan. Anak yang stunting berpotensi memiliki produktivitas yang lebih rendah di masa dewasa, sehingga memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Salah satu akar permasalahan stunting adalah ketidakcukupan asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, periode yang sangat penting untuk pertumbuhan

dan perkembangan anak. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, serta keterbatasan akses terhadap pangan bergizi dan pelayanan kesehatan yang memadai, menjadi faktor utama yang memengaruhi prevalensi stunting. Dalam konteks ini, optimalisasi pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber bahan makanan tambahan memiliki beberapa keunggulan. Pangan lokal tidak hanya kaya akan nutrisi, tetapi juga lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat setempat. Selain itu, pengolahan pangan lokal dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan, melalui pelatihan dan kegiatan memasak (*cooking class*) yang melibatkan ibu-ibu dan kader posyandu. Hal ini sejalan dengan prinsip pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan dan gizi anak.

Pelaksanaan *cooking class* dan pelatihan kader menjadi salah satu intervensi kunci dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan cara mengolah makanan yang bernutrisi. Kader posyandu, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat komunitas, memainkan peran strategis dalam menyampaikan informasi dan memantau perkembangan kesehatan balita. Dengan peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan yang terstruktur, diharapkan intervensi ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan prevalensi stunting.

Dalam buku monograf ini, kami menyajikan pendekatan intervensi berbasis komunitas untuk mengatasi stunting melalui optimalisasi pemberian makanan tambahan, *cooking class*, dan pelatihan kader. Pendekatan ini dirancang dengan mengutamakan pemanfaatan pangan lokal, yang tidak hanya

mendukung kesehatan balita, tetapi juga keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas, dalam merancang dan melaksanakan program penurunan stunting secara efektif.

Melalui pembahasan yang komprehensif, buku ini mengulas latar belakang permasalahan stunting, pentingnya pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, pelaksanaan cooking class dan pelatihan kader, hingga dampaknya terhadap kesehatan dan kebugaran balita. Dengan mengacu pada hasil penelitian dan studi kasus di beberapa daerah, kami juga menyajikan best practices yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan menyesuaikan kebutuhan lokal.

Sebagaimana diungkapkan oleh UNICEF (2020), intervensi berbasis komunitas yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga hingga pemerintah daerah, merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengatasi stunting. Oleh karena itu, pendekatan yang kami tawarkan dalam buku ini berfokus pada kolaborasi lintas sektor dan penguatan peran masyarakat. Dengan demikian, program ini tidak hanya menargetkan hasil jangka pendek berupa peningkatan status gizi balita, tetapi juga dampak jangka panjang berupa peningkatan kualitas hidup generasi mendatang.

Dalam konteks global, upaya untuk mengatasi stunting juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut di Indonesia.

Sebagai kesimpulan, stunting merupakan tantangan multidimensional yang membutuhkan pendekatan holistik dan partisipatif. Dengan memanfaatkan potensi pangan lokal, melibatkan masyarakat melalui cooking class, dan memperkuat kapasitas kader, kita dapat bersama-sama mewujudkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Buku ini adalah wujud komitmen kami untuk mendukung upaya tersebut dan menjadi bagian dari solusi yang berkelanjutan.

Masalah stunting di Indonesia telah menjadi isu yang sangat penting dalam bidang kesehatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan anak. Stunting, yang diartikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, tidak hanya memengaruhi tinggi badan, tetapi juga berdampak pada perkembangan otak, kemampuan kognitif, dan kapasitas fisik anak. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) dan Badan Kesehatan Dunia lainnya, Indonesia masih menghadapi prevalensi stunting yang tinggi. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya lebih lanjut untuk mengurangi angka stunting, salah satunya melalui intervensi yang berbasis pada pemberian makanan tambahan yang tepat dan bergizi.

Pemberian makanan tambahan yang berbasis pada pangan lokal menjadi salah satu solusi efektif dalam mengatasi masalah stunting. Pangan lokal, yang tersedia melimpah di berbagai daerah, dapat memberikan alternatif sumber gizi yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kondisi lokal. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan pangan lokal yang kaya akan zat gizi mikro, seperti vitamin A, zat besi, dan seng, dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, khususnya balita yang dalam masa pertumbuhan yang sangat pesat.

Namun, pemberian makanan yang bergizi saja tidak cukup untuk mengatasi stunting secara menyeluruh. Dibutuhkan pula pendekatan holistik yang mencakup berbagai faktor, seperti pengetahuan ibu atau pengasuh tentang pola makan sehat, keterampilan memasak yang tepat, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kader gizi yang dapat memberikan edukasi dan pendampingan langsung kepada keluarga. Di sinilah peran penting dari program-program yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam mengelola dan mengoptimalkan asupan gizi untuk anak-anak mereka.

Cooking class atau kelas memasak, sebagai salah satu metode dalam pemberian pelatihan dan edukasi gizi kepada ibu dan keluarga, terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan memasak makanan sehat berbasis pangan lokal. Kelas ini tidak hanya mengajarkan cara mengolah makanan yang bergizi, tetapi juga memberikan pengetahuan praktis mengenai nilai gizi dalam bahan makanan lokal, sehingga ibu dapat lebih kreatif dalam menyajikan menu yang beragam dan bergizi. Melalui pengajaran langsung, diharapkan dapat menciptakan perubahan pola makan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pelatihan kader juga memegang peranan penting dalam meningkatkan keberlanjutan program kesehatan. Kader kesehatan yang terlatih dapat menjadi agen perubahan di masyarakat dengan memberikan informasi yang benar mengenai gizi seimbang, cara mencegah dan mengatasi stunting, serta mendampingi keluarga dalam menyusun pola makan yang sesuai untuk balita mereka. Pelatihan kader ini juga berfungsi untuk memperkuat jejaring sosial yang saling mendukung dalam penanggulangan stunting di tingkat komunitas.

Buku monograf ini bertujuan untuk mengupas lebih dalam mengenai strategi optimalisasi pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, peran cooking class dalam meningkatkan keterampilan memasak yang sehat, serta pentingnya pelatihan kader dalam meningkatkan kesehatan dan kebugaran balita. Dengan pendekatan yang berbasis pada pemahaman lokal dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan dapat tercapai suatu sistem yang berkelanjutan dalam upaya menurunkan angka stunting, sehingga memberikan dampak positif bagi masa depan anak-anak Indonesia.

Dalam bagian-bagian selanjutnya, buku ini akan membahas secara rinci mengenai latar belakang stunting, faktor-faktor penyebabnya, serta berbagai intervensi yang telah diterapkan di Indonesia. Pembahasan akan berfokus pada peran pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal yang bergizi, keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi cooking class, serta kontribusi pelatihan kader dalam memberdayakan masyarakat untuk menangani stunting secara efektif. Di akhir buku, penulis akan menyimpulkan dengan rekomendasi untuk memperkuat upaya-upaya yang telah dilakukan, serta memberikan saran bagi kebijakan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah stunting yang masih menjadi tantangan besar bagi kesehatan generasi penerus bangsa.

Stunting, atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka stunting yang tinggi. Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia mencapai 30,8%, jauh di atas ambang batas yang ditetapkan WHO sebesar 20% (Kemenkes RI, 2019).

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga menghambat perkembangan kognitif yang dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Faktor penyebab stunting sangat kompleks dan multidimensional, melibatkan aspek gizi, kesehatan, pola asuh, sanitasi, serta akses terhadap pangan bergizi. Salah satu strategi yang telah banyak digunakan untuk mengatasi stunting adalah intervensi pemberian makanan tambahan (PMT). Namun, efektivitas PMT seringkali terkendala oleh kurangnya keterjangkauan bahan pangan bergizi, kurangnya pengetahuan tentang pengolahan makanan sehat, serta minimnya keterlibatan masyarakat, terutama kader posyandu, dalam program kesehatan balita.

Dalam konteks inilah, pemanfaatan pangan lokal menjadi solusi strategis yang dapat memberikan nilai tambah. Pangan lokal tidak hanya lebih terjangkau dan mudah diakses, tetapi juga kaya akan kandungan gizi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan balita. Melalui pengembangan program yang berbasis pangan lokal, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dalam menciptakan pola makan sehat untuk anak-anak mereka.

Program ini juga diperkuat dengan kegiatan *cooking class* dan pelatihan kader yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengolah makanan sehat berbasis pangan lokal. Dengan pendekatan partisipatif, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya gizi seimbang dalam mencegah stunting. Sebagaimana dinyatakan oleh Gibson et al. (2020), pelatihan berbasis komunitas dapat memperkuat kapasitas lokal dan

memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Pendekatan yang holistik melalui kombinasi PMT berbasis pangan lokal, *cooking class*, dan pelatihan kader diharapkan dapat menjadi model intervensi yang efektif dalam menurunkan prevalensi stunting. Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030, khususnya tujuan kedua, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan nutrisi.

Buku monograf ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi program intervensi berbasis pangan lokal, *cooking class*, dan pelatihan kader dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kebugaran balita. Dengan berbasis pada kajian empiris dan praktik terbaik, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi kesehatan, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam merancang program penanggulangan stunting yang berkelanjutan.

BAB 2

PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BERBASIS PANGAN LOKAL PADA BALITA

A. Pengertian Makanan Tambahan

Makanan tambahan merupakan makanan yang diberikan kepada balita untuk memenuhi kecukupan gizi yang diperoleh balita dari makanan sehari-hari yang diberikan ibu (Kemenkes RI, 2011).

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada sasaran perlu dilakukan secara benar sesuai aturan konsumsi yang dianjurkan. Pemberian makanan tambahan yang tidak tepat sasaran, tidak sesuai aturan konsumsi, akan menjadi tidak efektif dalam upaya pemulihan status gizi sasaran serta dapat menimbulkan permasalahan gizi. Makanan Tambahan Balita adalah suplementasi gizi berupa makanan tambahan dalam bentuk biskuit dengan formulasi khusus dan difortifikasi dengan vitamin dan mineral yang diberikan kepada bayi dan anak balita usia 6-59 bulan dengan kategori kurus. Bagi bayi dan anak berumur 6-24 bulan, makanan tambahan ini digunakan bersama Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan. Makanan tambahan penyuluhan adalah makanan tambahan yang diberikan kepada sasaran untuk mempertahankan status gizi normal

dengan waktu pemberian maksimal selama 1 bulan. Makanan tambahan pemulihan adalah makanan tambahan yang diberikan untuk meningkatkan status gizi pada sasaran (Kemenkes 2017). Menurut Persagi (2009), pemberian tambahan makanan di samping makanan yang dimakan sehari-hari dengan tujuan memulihkan keadaan gizi dan kesehatan. PMT dapat berupa makanan lokal atau makanan pabrik.

Makanan tambahan diberikan sebagai : a. Makanan Tambahan Penyuluhan adalah makanan tambahan yang diberikan untuk mencegah terjadinya masalah gizi. b. Makanan Tambahan Pemulihan adalah makanan tambahan yang diberikan untuk mengatasi terjadinya masalah gizi yang diberikan selama 90 hari makan Berikut standar pemberian makanan tambahan Balita dalam bentuk biskuit untuk tiap kelompok sasaran (Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan, 2020)

B. Tujuan dan Syarat Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

1. Tujuan

Masalah berat badan kurang pada balita disebabkan karena konsumsi gizi yang tidak mencukupi kebutuhannya dalam waktu tertentu. Kekurangan berat badan yang berlangsung pada anak yang sedang tumbuh merupakan masalah serius. Kondisi ini mencerminkan kebiasaan makan yang buruk (Paramitha et al, 2022).

Masalah gizi pada ibu hamil salah satunya adalah Kurang Energi Kronis (KEK). Di Indonesia batas ambang LILA dengan risiko KEK adalah 23,5 cm hal ini berarti ibu hamil dengan risiko KEK diperkirakan akan melahirkan bayi BBLR. Bila bayi lahir dengan berat badan lahir rendah

(BBLR) akan mempunyai risiko kematian, gizi kurang, gangguan pertumbuhan, dan gangguan perkembangan anak. Untuk mencegah risiko KEK pada ibu hamil sebelum kehamilan wanita usia subur sudah harus mempunyai gizi yang baik, misalnya dengan LILA tidak kurang dari 23,5 cm (Paramitha et al, 2024).

Pemberian makanan tambahan kepada kelompok rawan gizi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi yang pada akhirnya dapat meningkatkan status gizi sasaran. Peran serta semua pihak sangat diharapkan dalam mendukung keberhasilan kegiatan pemberian makanan tambahan kepada sasaran (Kemenkes RI, 2017).

2. Syarat

Makanan Tambahan Balita adalah suplementasi gizi berupa makanan tambahan dalam bentuk biskuit dengan formulasi khusus dan difortifikasi dengan vitamin dan mineral yang diberikan kepada bayi dan anak balita usia 6-59 bulan dengan kategori kurus. Bagi bayi dan anak berumur 6-24 bulan, makanan tambahan ini digunakan bersama Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI). Tiap kemasan primer (4 keping/40 gram) Makanan Tambahan Balita mengandung minimum 160 Kalori, 3,2-4,8 gram protein, 4-7,2 gram lemak. Makanan Tambahan Balita diperkaya dengan 10 macam vitamin (A, D, E, K, B1, B2, B3, B6, B12, Asam Folat) dan tujuh macam mineral yaitu, Besi, Iodium, Seng, Kalsium, Natrium, Selenium, dan Fosfor (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

C. Jenis dan Kandungan Gizi Makanan Tambahan

Makin bertambahnya usia anak makin bertambah pula kebutuhan makanannya, secara kuantitas maupun kualitas. Untuk memenuhi kebutuhannya tidak cukup dari susu saja. Di samping itu anak mulai diperkenalkan pola makanan dewasa secara bertahap dan anak mulai menjalani masa penyapihan. Jenis makanan tambahan yang diperkenalkan pada balita adalah hidangan yang bervariasi dengan menu seimbang (Adibin, 2018).

Menurut Rosidi et al, 2023 secara umum ada 3 kegunaan makanan bagi tubuh (triguna makanan), yakni sumber tenaga (karbohidrat, lemak dan protein), sumber zat pembangun (protein, air) dan sumber zat pengatur (vitamin dan mineral).

Zat gizi terbagi menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Zat gizi yang termasuk kelompok zat gizi makro yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil atau sedikit tetapi ada dalam makanan. Zat gizi yang termasuk kelompok zat gizi mikro adalah mineral dan vitamin (Rosidi et al, 2023).

1. Karbohidrat

Menurut Almtsier (2009) fungsi dari karbohidrat antara lain:

- a. Sebagai sumber energi, satu gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori.
- b. Pemberi rasa manis pada makanan, khususnya pada monosakarida pada disakarida.
- c. Penghemat protein, jika karbohidrat makanan tidak tercukupi maka protein akan digunakan untuk

memenuhi kebutuhan energi dengan mengalahkan fungsi utamanya sebagai zat pembangun.

- d. Pengatur metabolisme lemak, karbohidrat akan mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna, sehingga menghasilkan bahan-bahan keton berupa asam asetoasetat, aseton, dan asam beta-hidro-butirat. Bahan-bahan ini dibentuk dalam hati dan dikeluarkan melalui urine dengan mengikat basa berupa ion natrium. Hal ini dapat menyebabkan ketidak seimbangan natrium dan dehidrasi, serta PH cairan tubuh menurun.
- e. Membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltic usus dan memberi bentuk pada feses.

2. Protein

Menurut Almatier (2009) fungsi protein yaitu :

- a. Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh.
- b. Pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, hormon-hormon seperti tiroid, insulin, dan epinephrin adalah protein, demikian pula berbagai enzim.
- c. Mengatur keseimbangan air, cairan-cairan tubuh terdapat dalam tiga kompartemen: intraseluler (di dalam sel), ekstraseluler/ interselular (di luar sel), intravaskular (di dalam pembuluh darah).
- d. Memelihara netralitas tubuh, protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan asam basa untuk pH pada taraf konstan.
- e. Pembentukan anti bodi, kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi bergantung pada kemampuan tubuh memproduksi anti bodi.

- f. Mengangkut zat-zat gizi dari saluran cerna ke dalam darah, dari darah ke jaringan-jaringan, dan melalui membran sel ke dalam sel-sel.
- g. Sebagai sumber energi, protein ekivalen dengan karbohidrat karena menghasilkan 4 kalori/g protein.

3. Lemak

Menurut almatsier (2009) klasifikasi lipida menurut fungsi biologisnya di dalam tubuh yaitu :

- a. Lemak simpanan yang terutama terdiri atas trigliserida yang disimpan di dalam depot-depot di dalam jaringan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lemak merupakan simpanan sumber zat gizi esensial. Komposisi asam lemak trigliserida simpanan lemak ini bergantung pada susunan lemak.
- b. Lemak struktural yang terutama terdiri atas fosfolipida dan kolesterol. Di dalam jaringan lunak lemak struktural ini, sesudah protein merupakan ikatan struktural paling penting di dalam tubuh. Di dalam otak lemak-lemak struktural terdapat dalam konsentrasi tinggi.

Fungsi lemak menurut Almatsier (2009) adalah sebagai berikut:

- a. Lemak merupakan sumber energi paling padat yang menghasilkan 9 kalori untuk setiap gram, yaitu 2,5 kali besar 17 energi yang dihasilkan oleh karbohidrat dan protein dalam jumlah yang sama.
- b. Lemak merupakan sumber asam lemak esensial, asam linoleat, dan linolat.
- c. Alat angkut vitamin larut lemak yaitu membantu transportasi dan absorpsi vitamin larut lemak A, D, E, dan K.

- d. Menghemat penggunaan protein untuk sintesis protein, sehingga protein tidak digunakan sebagai sumber energi.
- e. Memberi rasa kenyang dan kelezatan, lemak memperlambat sekresi asam lambung, dan memperlambat pengosongan lambung, sehingga lemak memberi rasa kenyang lebih lama. Disamping itu lemak memberi tekstur yang disukai dan memberi kelezatan khusus pada makanan.
- f. Sebagai pelumas dan membantu pengeluaran sisa pencernaan.
- g. Memelihara suhu tubuh, lapisan lemak dibawah kulit mengisolasi tubuh dan mencegah kehilangan panas secara cepat, dengan demikian lemak berfungsi juga dalam memelihara suhu tubuh.
- h. Pelindung organ tubuh, lapisan lemak yang menyelubungi organ tubuh seperti jantung, hati, dan ginjal membantu menahan organ tersebut tetap di tempatnya dan melindungi terhadap benturan dan bahaya lain.

4. Vitamin

Vitamin adalah zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Oleh karena itu, harus didatangkan dari makanan. Vitamin termasuk kelompok zat pengatur pertumbuhan dan pemeliharaan kehidupan. Tiap vitamin mempunyai tugas spesifik di dalam tubuh. Karena vitamin adalah zat organik maka vitamin dapat rusak karena penyimpanan dan pengolahan. Fungsi utama vitamin adalah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Menurut sifatnya vitamin digolongkan menjadi dua, yaitu

vitamin larut dalam lemak vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C (Almatsier, 2009). Vitamin merupakan senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit untuk mengatur fungsi-fungsi tubuh yang spesifik, seperti pertumbuhan normal, memelihara kesehatan dan reproduksi (Irianto, 2007).

5. Mineral

Menurut Irianto (2007) mineral merupakan zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah kecil untuk membantu reaksi fungsional tubuh, misalnya untuk memelihara keteraturan metabolisme. Dalam tubuh manusia mineral terdapat sekitar kurang lebih 4%. Mineral paling banyak dalam tubuh manusia adalah kalsium yang terdapat lebih dari 99%, sedangkan mineral paling banyak kedua dalam tubuh manusia setelah kalsium adalah fosfor sekitar 85%. Kedua mineral dalam tubuh ini banyak terdapat dalam tulang.

Mineral merupakan unsur yang dibutuhkan oleh tubuh manusia yang mempunyai peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Unsur ini digolongkan ke dalam mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg sehari, misalnya natrium, klor, kalsium, kalium, magnesium, sulfur dan fosfor, sedangkan mineral mikro dibutuhkan kurang dari 100 mg sehari, misalnya besi, iodium, mangan, tembaga, zink, kobalt dan fluor (Almatsier, 2009).

Kemenkes RI (2017) menyatakan makanan tambahan balita adalah suplementasi gizi berupa makanan tambahan dalam bentuk biskuit dengan

formulasi khusus dan difortifikasi dengan vitamin dan mineral yang diberikan kepada bayi dan anak balita usia 6-59 bulan dengan kategori kurus. Bagi bayi dan anak berumur 6-24 bulan, makanan tambahan ini digunakan bersama Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). Tiap kemasan primer (4 keping/40 gram) Makanan Tambahan Balita mempunyai kandungan gizi sebagai berikut:

- a. 160 Kalori
- b. 3,2-4,8 gram protein
- c. 4-7,2 gram lemak 16
- d. Diperkaya dengan 10 macam vitamin (A, D, E, K, B1, B2, B3, B6, B12, Folat) dan 7 macam mineral (Besi, Iodium, Seng, Kalsium, Natrium, Selenium, Fosfor).

Kemenkes RI (2017) menyatakan makanan tambahan ibu hamil adalah suplementasi gizi berupa biskuit lapis yang dibuat dengan formulasi khusus dan difortifikasi dengan vitamin dan mineral yang diberikan kepada ibu hamil dengan kategori Kurang Energi Kronis (KEK) untuk mencukupi kebutuhan gizi. Tiap kemasan primer (3 keping/60 gram) Makanan Tambahan Ibu Hamil mempunyai kandungan gizi sebagai berikut:

- a. 270 Kalori
- b. Minimum 6 gram protein
- c. Minimum 12 gram lemak
- d. Diperkaya 11 macam vitamin (A, D E, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, Folat) dan 7 macam mineral (Besi, Kalsium, Natrium, Seng, Iodium, Fosfor, Selenium).

Kemenkes RI (2017) menyatakan makanan Tambahan Anak Sekolah adalah suplementasi gizi berupa makanan tambahan dalam bentuk krekers/biskuit dengan formulasi khusus dan difortifikasi dengan vitamin dan

mineral yang diberikan kepada anak usia Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dengan kategori kurus untuk mencukupi kebutuhan gizi. Tiap kemasan primer (6 keping/36 gram) makanan tambahan anak Sekolah mempunyai kandungan gizi sebagai berikut :

- a. 144-216 Kalori
- b. 3,96-5,76 gram protein
- c. 5,04-7,56 gram lemak.
- d. Diperkaya 11 macam vitamin (A, D E, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, Folat) dan 7 macam mineral (Besi, Kalsium, Natrium, Seng, Iodium, Fosfor, Selenium).

Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah banyaknya zat-zat minimal yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan status gizi yang adekuat. AKG yang dianjurkan didasarkan pada patokan berat badan untuk masing-masing kelompok umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis tertentu seperti kehamilan dan menyusui (Almatsier, 2009). Peraturan Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi pada kelompok umur yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1: Angka Kecukupan Gizi pada Bayi/Anak

Kelompok Umur	Energi (Kkal)	Protein (g)	Lemak (g)	Karbohidrat (g)
0-6 bulan	550	12	34	58
7-11 bulan	725	18	36	82
1-3 tahun	1125	26	44	155
4-6 tahun	1600	35	62	220
7-9 tahun	1850	49	72	254

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sasaran. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

dikonsumsi balita dan ibu hamil sebagai tambahan makanan sehari-hari, bukan sebagai pengganti makanan utama. Oleh karena itu, diharapkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang berupa biskuit ini dapat membantu mencukupi kebutuhan gizi. Prinsip penentuan zat gizi yaitu berdasarkan angka atau nilai asupan gizi untuk mempertahankan kondisi sehat sesuai kelompok umur atau tahap pertumbuhan dan perkembangan jenis kelamin, kegiatan dan kondisi fisiologisnya.

D. Pangan Lokal sebagai Makanan Tambahan

Makin bertambahnya usia anak makin bertambah pula kebutuhan makanannya, secara kuantitas maupun kualitas. Untuk memenuhi kebutuhannya tidak cukup dari susu saja. Di samping itu anak mulai diperkenalkan pola makanan dewasa secara bertahap dan anak mulai menjalani masa penyapihan. Jenis makanan tambahan yang diperkenalkan pada balita adalah hidangan yang bervariasi dengan menu seimbang (Adibin, 2018).

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal merupakan salah satu strategi penanganan masalah gizi pada Balita dan upaya pencegahan stunting. PMT berbahan pangan lokal ini bukan untuk menggantikan makanan utama. PMT diberikan setiap hari dengan komposisi 6 sedikitnya 1 kali makanan lengkap dalam seminggu dan sisanya kudapan (Hadju et al., 2023).

Makanan lokal biasanya bersumber dari pekarangan rumah, kebun, bahkan laut. Banyak jenis ikan yang bisa dikonsumsi oleh balita bukan hanya salmon. Beberapa diantaranya bahkan jauh lebih tinggi Omega-3 nya dibanding salmon, contohnya saja Ikan Kembung dan Ikan lele. Dua jenis ikan ini baik sekali untuk pertumbuhan dan

perkembangan anak. Tinggi protein dan omega 3, hanya saja sering dianggap sebelah mata. Padahal kalau orang tua bisa memanfaatkan, sangat bisa diolah beragam menjadi pangan lokal yang baik bagi anak.

Ikan baik sekali bagi perkembangan anak, karena mengandung protein yang bagus bagi pertumbuhan mereka. Ikan juga mudah dicerna dan diolah serta bisa juga memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak.

Selanjutnya, ikan terdapat kandungan asam lemak jenuh yang bisa menurunkan kadar yang ada pada kolesterol darah. Dan Omega 3 asam lemak juga terdapat pada ikan laut dan berperan dalam perkembangan sel otak pada janin, bayi, dan anak kecil serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ada juga berbagai jenis vitamin seperti vitamin A, B kompleks, dan D yang membantu menjaga kesehatan mata, menghasilkan energi, memetabolisme karbohidrat, menjaga kesehatan jantung, mendukung sistem saraf, dan membentuk sel darah merah juga mencegah anemia.

Kalsium membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi, dan zat besi membantu membentuk sel darah merah dan menghasilkan energi, menyerap kalsium, dan menjaga kekuatan tulang. Selain ikan, juga ada rumput laut yang mengandung vitamin A, vitamin K, yodium vitamin B12, kalsium, zat besi, eritrat, asam lemak omega-3 yang berperan dalam pembekuan darah.

Banyak juga pangan lokal yang dapat dijadikan sumber energi, karbohidrat, dan unsur hara lainnya di pekarangan rumah, seperti pepaya, tauge ubi jalar, ubi jalar, singkong, jagung, pisang, lalu labu kuning, dan talas (Rifana Chorid et al, 2018).

Selain ikan, ada tanaman seperti kelor yang bagus sekali dalam mencegah stunting. Pangan lokal merupakan

sumber yang baik dalam mencegah terjadinya stunting. Salah satu pangan lokal yang sedang populer adalah daun kelor. Kandungan daun kelor lebih baik dibandingkan wortel karena mengandung beta karoten lebih tinggi empat kali lipat, kemudian juga lebih baik dibanding pisang karena mengandung potassium tiga kali lipatnya (Krisnadi, 2015). Daun kelor kaya akan zat gizi yang baik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Namun pengolahannya masih sangat terbatas karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan manfaat tanaman tersebut (Susanti et al., 2022).

Pengetahuan mengenai kelor masih sangat terbatas, sehingga anak-anak banyak yang kurang menyukai. Mengingat manfaat yang signifikan bagi kesehatan dan kebutuhan gizi anak, maka pengolahan pangan lokal harus dilakukan diversifikasi untuk meningkatkan kandungan gizi makanan agar lebih memenuhi kebutuhan anak dan juga berkontribusi terhadap pencegahan stunting dan memberikan nilai tambah (Ariani et al., 2013). Ada beberapa perbandingan antara kelor segar dan kering dalam hal nilai gizi. Kelor segar mengandung potasium tiga kali lebih banyak dibandingkan pisang, sedangkan kelor kering mengandung potasium 15 kali lebih banyak dibandingkan pisang. Kelor segar mengandung vitamin A empat kali lebih banyak dibandingkan wortel, sedangkan kelor kering mengandung vitamin A sepuluh kali lebih banyak dibandingkan wortel. Kelor segar mengandung setara zat besi 25 kali lebih banyak dibandingkan bayam dibandingkan kelor kering dengan kandungan zat yang sama, kelor segar memiliki vitamin C tujuh kali lebih banyak dibandingkan jeruk, sedangkan kelor kering memiliki setengah vitamin C dari jeruk. Kelor segar mengandung kalsium empat kali lebih

banyak dibandingkan susu, sedangkan kelor kering mengandung kalsium 17 kali lebih banyak dibandingkan susu. Kandungan protein kelor segar dua kali lipat dari yogurt, sedangkan kandungan protein kelor kering sembilan kali lipat dari yogurt (Citra, 2019).

Nutrisi ini mutlak diperlukan bagi ibu hamil dan terutama pada anak di bawah 2 tahun untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, es krim daun kelor yang manis dan menyehatkan serta populer di kalangan anak-anak ini dibuat dengan menggunakan tanaman bernama daun kelor. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat es krim daun kelor relatif mudah didapat dan pengolahannya tidak memerlukan modal besar. Selain itu, daun kelor tersedia berlimpah di lingkungan yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

1. Prinsip dan Persyaratan Makanan Tambahan Lokal

Prinsip Pemberian Makanan Tambahan Lokal adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian makanan tambahan lokal merupakan kegiatan di luar Gedung Puskesmas dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan lintas program dan sektor terkait lainnya.
- b. Pemberian makanan tambahan lokal ini sebagai contoh menu lengkap sekali makan (makan siang) bagi ibu hamil dan balita yang diharapkan dapat diterapkan dalam penyediaan makanan sehari-hari di keluarga.
- c. Bentuk makanan tambahan lokal adalah makanan lengkap, sesuai dengan "Isi Piringku" dan Pedoman Gizi Seimbang terdiri dari sumber Karbohidrat, Protein Hewani dan Nabati, Lemak, Vitamin dan Mineral.

- d. Pemberian makanan tambahan lokal pada sasaran harus disertai dengan penguatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

2. Persyaratan Makanan Tambahan Lokal

Pemberian makanan tambahan lokal harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Dapat diterima

Makanan untuk ibu hamil dan balita diharapkan dapat diterima dalam hal bentuk, rasa dan biasa dikonsumsi sehari-hari. Bentuk dan rasa makanan dibuat bervariasi dan disesuaikan dengan selera sasaran sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Makanan yang berbau tajam, pedas, terlalu asam, manis, asin kurang baik bagi kesehatan.

- b. Sesuai dengan Norma dan Agama

Pemberian makanan tambahan lokal mempertimbangkan norma dan keyakinan yang berlaku pada masyarakat setempat.

- c. Mudah Dibuat

Makanan bagi ibu hamil dan balita hendaknya mudah dibuat dengan menggunakan peralatan masak yang tersedia di rumah tangga atau yang tersedia di masyarakat, serta pembuatannya tidak memerlukan waktu terlalu lama.

- d. Memenuhi kebutuhan zat gizi

Makanan hendaknya memenuhi kebutuhan zat gizi sasaran dan memiliki daya cerna baik. Daya cerna yang baik dapat dicapai dengan teknik pengolahan makanan yang benar. Kebutuhan zat gizi ibu hamil lebih besar dibandingkan dengan kelompok sasaran lainnya.

- e. Terjangkau

Makanan dapat diolah dari bahan makanan yang harganya terjangkau oleh masyarakat ekonomi rendah dan tetap dapat memenuhi kebutuhan gizi, keamanan pangan dan selera sasaran. Bahan makanan yang digunakan dapat dan mudah dibeli di daerah setempat.

f. Mudah didapat

Bahan makanan yang digunakan mudah didapat sepanjang tahun, sebaiknya bahan makanan setempat yang diproduksi dan dijual di wilayah tersebut. Dengan menggunakan bahan makanan setempat diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan melalui pengembangan dan pendayagunaan potensi wilayah.

g. Aman

Makanan harus aman, tidak mengandung bahan pengawet, zat pewarna dan zat aditif lainnya. Makanan yang aman adalah makanan yang bebas dari kuman dan bahan kimia yang berbahaya serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat (halal). Cara penanganan makanan yang baik meliputi cara: mempersiapkan, menyimpan, mencuci, mengolah atau memasak, menyimpan makanan matang yang baik dan benar. Dengan penanganan makanan yang baik maka makanan akan terhindar dari kemungkinan tercemar kuman dan bahan kimia yang membahayakan kesehatan. Tanda-tanda umum makanan yang tidak aman bagi kesehatan antara lain: berlendir, berjamur, aroma dan rasa makanan berubah. Tanda lain dari makanan yang tidak memenuhi syarat aman adalah bila dalam pengolahannya ditambahkan bahan tambahan berbahaya seperti asam borax/ bleng,

formalin, zat pewarna *rhodamine A* dan *methanil yellow*.

h. Kandungan Gizi

Pemberian makanan tambahan lokal bagi balita dalam bentuk makanan lengkap dari bahan makanan lokal sesuai jenis, karakteristik dan kandungan gizi untuk 10 masing-masing sasaran. Makanan yang diberikan kaya zat gizi berupa sumber karbohidrat (nasi, jagung, sagu, kentang, singkong dll), sumber protein hewani (telur, ikan, ayam, daging dll) maupun protein nabati (tahu, tempe, kacang-kacangan atau hasil olahan lainnya) serta vitamin dan mineral yang berasal dari sayuran buah-buahan. Menu makanan tambahan dibuat sederhana yang berasal dari makanan keluarga dan disesuaikan dengan selera serta mudah dikenal atau sudah biasa dikonsumsi.

3. Cara Pengolahan PMT Lokal

Pengolahan makanan dilakukan sesuai dengan cara pengolahan yang biasa dilakukan sehari-hari dengan memperhatikan aspek higiene dan sanitasi. Dalam hal ini, bahan makanan harus dicuci sampai bersih, air yang digunakan juga air bersih yang layak minum. Selain itu, peralatan yang digunakan harus bersih dan orang yang mengolah makanan juga harus menjaga kebersihan diri. Prinsip-prinsip dalam pengolahan bahan makanan perlu diperhatikan untuk mempertahankan zat gizi yang terkandung dalam bahan makanan serta meningkatkan daya cerna makanan. Teknis pengolahan makanan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2: Teknis pengolahan makanan tersebut dapat dilihat dalam tabel

No.	Cara Pengolahan	Prinsip
1.	Merebus	• Gunakan air bersih secukupnya • Semua bahan terendam • Air mendidih (suhu 100° C) • Lama perebusan sampai tingkat kematangan yang dikehendaki termasuk bagian dalam bahan makanan
2.	Mengukus	• Gunakan air bersih secukupnya • Lama pengukusan sampai tingkat kematangan yang dikehendaki termasuk bagian dalam bahan makanan
3.	Memanggang	• Panaskan alat panggang (oven) sampai panas yang dikehendaki sebelum bahan dimasukkan • Lama pemanggangan sampai tingkat kematangan yang dikehendaki termasuk bagian dalam bahan makanan
4.	Membakar	• Siapkan bahan pembakar (arang/kayu) sampai terbentuk bara api sebelum bahan makanan dibakar • Lama pembakaran sampai tingkat kematangan yang dikehendaki termasuk bagian dalam bahan makanan
5.		• Gunakan minyak goreng secukupnya

		• Panaskan minyak goreng sampai panas dikehendaki sebelum bahan dimasukkan • Lama penggorengan sampai tingkat kematangan yang dikehendaki termasuk bagian dalam bahan makanan • Dianjurkan menggunakan minyak goreng yang sama tidak lebih dari 2 kali penggorengan
--	--	---

Sumber: Fellows. P.J, 2000. Food Processing Technology, Principles and Practice. Ellis Horood, New York

4. Contoh dan Porsi PMT Lokal

a. Contoh Menu Makanan Tambahan Lokal Untuk Bayi Usia 6 – 8 Bulan

Makanan keluarga yang disaring atau diblender dengan tekstur kental, misalnya:

- 1) Bubur saring ayam, tahu dan bayam
- 2) Bubur saring ikan, kacang merah dan wortel
- 3) Bubur saring hati ayam, tahu dan buncis

b. Contoh Menu Makanan Tambahan Lokal Untuk Bayi Usia 9 – 12 Bulan

Makanan keluarga dengan tekstur lebih kental atau makanan yang dicincang halus kental

- 1) Nasi tim, tempe dan sawi hijau
 - 2) Nasi tim, ayam kecap cincang dan kangkong
 - 3) Bubur pure, tumis hati ayam, tahu dan cah buncis
- Mulai usia 1 sampai dengan 5 tahun anak balita diberikan makanan keluarga dengan porsi lebih kecil

c. Contoh Menu Makanan Tambahan Lokal Untuk Bayi Usia 12 – 59 Bulan

Contoh Menu sekali makan :

1) Menu 1:

- a) Nasi = $\frac{1}{2}$ piring (100 gr)
- b) Ikan lele bumbu kuning = 1 potong sedang (75 gr)
- c) Tempe goreng = 2 potong sedang (50 gr)
- d) Tumis sayuran (buncis, wortel, kembang kol, kelor) = 1 mangkuk (100 gr)
- e) Pisang Ambon = 1 buah sedang (75 gr)

2) Menu 2:

- a) Nasi = $\frac{1}{2}$ piring (100 gr)
- b) Ayam goreng tepung = 1 potong sedang (40 gr)
- c) Tahu goreng = 2 potong sedang (100 gr)
- d) Sayur capcay (wortel, sawi putih dan sawi hijau)= 1 mangkuk (100 gr)
- e) Melon = 1 potong sedang (100 gr)

Porsi sekali makan untuk Balita usia 12- 59 bulan dapat dipenuhi dari:

- a. Nasi/ pengganti: $\frac{1}{2}$ piring (100 gram)
- b. Lauk Hewani: 1 potong sedang (40 gram)
- c. Lauk Nabati : 1 potong sedang (50 gram)
- d. Sayuran: 50 gram ($\frac{1}{2}$ mangkok)
- e. Buah: 50 gram (1 potong sedang)

Untuk Bayi usia 6-11 bulan makanan yang diberikan disesuaikan dengan usia, frekuensi, jumlah dan tekstur (lumat / lembik)

BAB 3

COOKING CLASS

A. Definisi dan Tujuan Cooking Class

Cooking class atau kelas memasak merupakan program edukasi dan pelatihan praktis yang dirancang untuk mengajarkan teknik memasak pemilihan bahan pangan, serta penyusunan menu yang sehat dan bergizi. Dalam konteks pemberian makanan tambahan untuk balita, *cooking class* berfokus pada pemberdayaan orang tua atau pengasuh dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyiapkan makanan yang tidak hanya lezat tetapi juga memenuhi kebutuhan nutrisi anak berdasarkan sumber pangan lokal yang tersedia di lingkungan mereka.

Cooking class mencakup berbagai aspek mulai dari dasar-dasar memasak, seperti pemilihan bahan, teknik pengolahan, hingga penyajian makanan yang menarik. Selain itu, kelas ini juga menekankan pentingnya penggunaan bahan pangan lokal yang berkelanjutan dan terjangkau, yang dapat diakses oleh keluarga di berbagai daerah. Dengan demikian, *cooking class* tidak hanya meningkatkan kemampuan memasak peserta tetapi juga mendukung keberlanjutan pangan lokal dan kemandirian dalam penyediaan makanan sehat.

cooking class merupakan intervensi yang efektif dalam meningkatkan kualitas makanan tambahan yang diberikan kepada balita. Program ini memberikan pengetahuan praktis dan langsung kepada orang tua tentang cara mengolah bahan pangan lokal menjadi

makanan yang bergizi dan menarik bagi anak. Selain itu, *cooking class* juga berfungsi sebagai wadah untuk berbagi pengalaman dan strategi antar peserta, sehingga menciptakan komunitas yang saling mendukung dalam upaya meningkatkan gizi anak.

Selain aspek teknis memasak, *cooking class* juga mencakup pendidikan gizi yang komprehensif. Peserta diajarkan tentang pentingnya berbagai makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan balita. Materi ini mencakup informasi tentang sumber makanan lokal yang kaya akan nutrisi penting seperti karbohidrat, lemak, zat besi, vitamin A, dan protein, yang semuanya berperan vital dalam mencegah stunting dan meningkatkan kesehatan anak secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, *cooking class* dapat dilakukan secara tatap muka maupun daring, tergantung pada kondisi dan kebutuhan peserta. Kelas tatap muka memungkinkan interaksi langsung antara instruktur dan peserta, serta kesempatan untuk melakukan praktik langsung di dapur. Sementara itu, kelas daring memberikan fleksibilitas bagi peserta yang memiliki keterbatasan waktu atau akses geografis, tanpa mengurangi kualitas pembelajaran.

Selain manfaat praktis, *cooking class* juga berkontribusi pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional peserta. Melalui kegiatan memasak bersama, orang tua dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan anggota keluarga dan menciptakan lingkungan makan yang lebih menyenangkan dan harmonis. Hal ini penting untuk membentuk kebiasaan makan yang sehat sejak dini dan meningkatkan kepatuhan anak terhadap pola makan yang seimbang. Selain itu, *cooking class* juga dapat

berperan dalam pelatihan kader kesehatan masyarakat. Kader yang terlatih dalam kelas memasak dapat menjadi agen perubahan di komunitas mereka, menyebarkan informasi tentang gizi dan teknik memasak sehat kepada lebih banyak orang tua. Ini membantu memperluas dampak program dan memastikan bahwa manfaat *cooking class* dapat dirasakan oleh lebih banyak keluarga di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, *cooking class* adalah komponen penting dalam upaya mengoptimalkan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal. Dengan memberikan keterampilan praktis, pengetahuan gizi, dan dukungan komunitas, *cooking class* berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesehatan dan kebugaran balita, serta upaya pencegahan stunting di tingkat masyarakat.

meningkatkan keterampilan memasak peserta, dalam hal ini orang tua, pengasuh, atau kader kesehatan, untuk menyiapkan makanan tambahan yang bergizi bagi balita.

Tujuan dari pelaksanaan *cooking class*, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengetahuan Nutrisi dan Teknik Memasak: Memberikan pemahaman tentang pentingnya nutrisi seimbang dan cara memasak yang mempertahankan nilai gizi makanan.
2. **Memfasilitasi Penggunaan Pangan Lokal yang Bergizi:** Mengajarkan penggunaan bahan makanan lokal yang mudah diakses dan bergizi untuk mendukung keberlanjutan dan Kesehatan.
3. **Membentuk Kebiasaan Makan Sehat Sejak Dini:** Mendorong pembentukan pola makan yang sehat pada balita melalui keterlibatan aktif orang tua dalam proses memasak.
4. **Peningkatan Kualitas Makanan Anak**

Membantu orang tua dalam menciptakan variasi menu yang menarik dan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nafsu makan dan asupan nutrisi balita.

5. **Penguatan Komunitas dan Kaderisasi**

Mengembangkan jaringan dukungan di antara para peserta *cooking class*, serta memperkuat peran kader dalam menyebarkan informasi dan praktik terbaik mengenai pemberian makanan tambahan yang optimal.

6. **Pencegahan Stunting**

Dengan memastikan balita mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang, *cooking class* berkontribusi langsung dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kesehatan serta kebugaran anak.

B. *Persiapan Cooking Class*

Pelaksanaan *Cooking Class* yang efektif memerlukan persiapan yang matang dan sistematis. Bab ini akan membahas langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program *cooking class* berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu optimalisasi pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, peningkatan kesehatan dan kebugaran balita, serta pencegahan stunting.

1. **Identifikasi Kebutuhan dan Analisis Situasi**

Identifikasi kebutuhan yang mendalam membantu dalam merancang program yang relevan dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga meningkatkan efektivitas intervensi. Sebelum memulai persiapan, penting untuk melakukan identifikasi kebutuhan dan

analisis situasi di komunitas target. Langkah ini melibatkan:

a. Survei Gizi Balita

Mengumpulkan data tentang status gizi balita di daerah tersebut, termasuk prevalensi stunting, kekurangan mikronutrien, dan faktor-faktor risiko lainnya.

b. Inventarisasi Sumber Daya Lokal

Menyusun daftar bahan pangan lokal yang tersedia, musiman, dan kaya nutrisi yang dapat dimanfaatkan dalam pemberian makanan tambahan.

c. Analisis Demografis

Memahami karakteristik peserta potensial, seperti tingkat pendidikan, latar belakang sosial-ekonomi, dan kebiasaan makan keluarga.

2. Pemilihan Lokasi dan Fasilitas

Lokasi yang strategis dan fasilitas yang memadai sangat penting untuk keberhasilan cooking class. Beberapa pertimbangan dalam pemilihan lokasi meliputi:

a. Aksesibilitas

Memilih Lokasi yang mudah dijangkau oleh peserta, baik dari segi transportasi maupun jarak geografis.

b. Kondisi Fasilitas

Memastikan bahwa Lokasi memiliki fasilitas dapur yang memadai, termasuk kompor, peralatan memasak, meja, kursi dan ventilasi yang baik.

c. Keamanan dan Kenyaman

Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk peserta, terutama jika melibatkan balita dalam proses memasak.

3. Pengadaan Bahan dan Peralatan Memasak

Ketersediaan bahan dan peralatan memasak yang memadai sangat penting untuk keberlangsungan program. Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi:

- a. Daftar Bahan Baku: Menyusun daftar bahan pangan lokal yang akan digunakan dalam setiap sesi memasak, memastikan ketersediaan dan keberlanjutan pasokan.
 - b. Peralatan Memasak: Menyediakan peralatan yang diperlukan, seperti kompor, panci, wajan, pisau, talenan, dan alat ukur. Pastikan peralatan dalam kondisi baik dan memenuhi standar kebersihan.
 - c. Pengelolaan Logistik: Mengatur pengadaan dan penyimpanan bahan serta peralatan agar tetap terjaga kualitasnya hingga digunakan.
4. Kolaborasi dengan Pihak Terkait
- Kerjasama dengan berbagai pihak terkait dapat memperkuat pelaksanaan *cooking class*. Beberapa pihak yang dapat diajak bekerjasama antara lain:
- a. Dinas Kesehatan dan Pertanian: Mendapatkan dukungan teknis dan logistik dari instansi pemerintah terkait.
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Bekerjasama dengan LSM yang fokus pada gizi dan pemberdayaan masyarakat untuk memperluas jangkauan program.
 - c. Komunitas Lokal: Melibatkan kelompok ibu, koperasi, atau kelompok tani dalam penyediaan bahan pangan lokal dan dukungan operasional.
 - d. Pusat Pendidikan: Menggunakan fasilitas pendidikan sebagai lokasi pelaksanaan dan sumber daya instruktur.

Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat sumber daya yang tersedia tetapi juga meningkatkan legitimasi dan penerimaan program di komunitas.

5. Penyusunan Jadwal dan Rencana Kerja
Menyusun jadwal yang terstruktur dan rencana kerja yang jelas membantu dalam pelaksanaan program yang efisien. Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi:
 - a. Penentuan Frekuensi dan Durasi: Menentukan berapa kali cooking class akan dilaksanakan dalam satu periode, serta durasi setiap sesi.
 - b. Rencana Kegiatan: Menyusun agenda kegiatan untuk setiap sesi, termasuk waktu untuk teori, demonstrasi, praktik, dan evaluasi.
 - c. Koordinasi Tim: Mengatur tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim pelaksana untuk memastikan kelancaran operasional.

C. Perencanaan dan Pelaksanaan *Cooking Class*

1. Identifikasi Kebutuhan Peserta

Dalam perencanaan dan pelaksanaan *cooking class* perlu memperhatikan beberapa hal, salah satunya adalah perlunya identifikasi kebutuhan peserta, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat diperoleh secara optimal. Mengidentifikasi kebutuhan peserta dapat dilakukan dengan;

- a. **Analisis Demografis:** Memahami latar belakang peserta, termasuk usia, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi, adalah langkah awal yang penting dalam perencanaan kelas memasak.
- b. **Kondisi Gizi Balita di Komunitas Target:** Mengidentifikasi masalah gizi yang umum di komunitas, seperti kekurangan zat besi atau vitamin, membantu dalam penyesuaian materi pembelajaran.
- c. **Survei Kebutuhan dan Preferensi Peserta:** Mengumpulkan data melalui kuesioner atau

wawancara untuk menyesuaikan materi kelas dengan kebutuhan dan preferensi peserta.

2. Struktur Kurikulum

- a. **Nutrisi Dasar:** Pemahaman tentang makronutrien dan mikronutrien yang penting untuk balita.
- b. **Teknik Memasak:** Metode memasak yang mempertahankan nilai gizi makanan, seperti mengukus, merebus, memanggang, dll.
- c. **Penggunaan Pangan Lokal:** Cara memilih dan memanfaatkan bahan pangan lokal yang tersedia sepanjang tahun, sehingga akan mempermudah bagi peserta mempraktikannya Kembali di rumah masing-masing. Penggunaan bahan pangan lokal dapat didukung dengan Kerjasama dengan pemasok lokal, yaitu dengan menjalin hubungan dengan petani dan produsen pangan, sehingga dapat mendukung ekonomi lokal dan memastikan kualitas bahan dengan bekerja sama langsung dengan produsen pangan. Selain itu, dapat dilakukan distribusi bahan melalui pasar local sehingga dapat mempermudah akses bahan bagi peserta kelas dengan memanfaatkan jaringan distribusi local yang ada.
- d. **Penggunaan Alat Masak yang Tepat dan Ramah Lingkungan:** Memilih peralatan memasak yang efisien dan aman dengan menggunakan alat yang mudah dioperasikan dan sesuai untuk memasak makanan balita, memastikan keamanan dan efisiensi serta menerapkan praktik ramah lingkungan untuk mengurangi limbah dan menggunakan peralatan yang berkelanjutan untuk mendukung lingkungan yang lebih hijau.

3. Metodologi Pengajaran dalam *Cooking Class*

Metode dalam pelaksanaan *cooking class* dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan pendekatan praktis dan interaktif, Dimana dalam pelaksanaannya dapat menggabungkan pemberian teori dengan praktik secara langsung untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam mengolah bahan pangan. Selain itu dapat juga dengan demonstrasi langsung dan praktik memasak Bersama dengan peserta, dimana pelaksanaan *cooking class* dengan menunjukkan Langkah-langkah memasak secara real-time dan memungkinkan peserta untuk mencoba resep secara langsung, sehingga dibutuhkan alat memasak yang mencukupi bagi peserta.

Metode pengajaran *cooking class* dapat didukung dengan materi maupun media yang dapat menarik minat bagi peserta, diantaranya adalah menyediakan materi yang sesuai untuk pemula dan peserta dengan pengalaman memasak sebelumnya untuk memastikan semua peserta dapat mengikuti; memanfaatkan video, gambar, dan bahan cetak yang informatif untuk mendukung proses pembelajaran dan membuat kelas lebih menarik; menyediakan sumber daya digital untuk mendukung belajar di luar kelas dan memungkinkan peserta mengakses resep kapan saja; dan menggunakan forum atau grup media sosial untuk diskusi dan berbagi pengalaman antar peserta.

4. Pengembangan Resep Berbasis Pangan Lokal

Pengembangan resep perlu memastikan bahwa resep mengandung nutrisi penting sesuai kebutuhan balita, seperti karbohidrat, lemak, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral serta mikronutrien lain yang

dapat mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal.

Penyesuaian konsistensi makanan dengan tahap perkembangan motorik makan balita sehingga dapat memfasilitasi kemampuan mengunyah dan menelan, tekstur disesuaikan dengan usia balita atau sesuai kemampuan balita, dari tekstur bubur lumat, bubur kental, agak kasar dan kasar.

Penggunaan bahan alami untuk menciptakan rasa yang disukai tanpa tambahan gula atau garam berlebih yang dapat berdampak negatif pada Kesehatan balita. Rasa makanan yang enak dapat meningkatkan nafsu makan anak sehingga dapat mengoptimalkan intake nutrisi pada anak. Menggunakan rempah alami seperti kayu manis, cengkeh, dan jahe untuk meningkatkan cita rasa tanpa menambah bahan pengawet berbahaya. Beberapa rempah memiliki manfaat kesehatan tambahan, seperti antioksidan atau anti-inflamasi, yang dapat meningkatkan nilai gizi makanan.

5. Pelaksanaan Sesi Praktik dan Demonstrasi

a. Demonstrasi

Langkah awal dalam melakukan *cooking class* adalah dengan menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan. Menjelaskan cara memilih dan menyiapkan bahan serta alat memasak yang diperlukan dalam pembuatan menu, dan memastikan kebersihan dan efisiensi dalam penggunaannya.

Langkah berikutnya menunjukkan setiap Langkah memasak dengan jelas dan detail, termasuk pengolahan bahan dan waktu memasak yang tepat, sehingga memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan resep yang telah dipelajari. Peserta

mempraktikkan langsung bagaimana cara mengolah makanan tambahan bagi balita diharapkan peserta mampu meningkatkan keterampilan praktis serta kepercayaan diri dalam memasak.

b. Keterlibatan dan Motivasi Peserta

Pelaksanaan *cooking class* perlu adanya keterlibatan dan motivasi dari peserta, oleh karena itu perlu adanya strategi untuk meningkatkan partisipasi aktif dari peserta. Membangun dinamika kelompok melalui tugas Bersama dan diskusi aktif dapat menciptakan lingkungan belajar yang supportif, membahas tantangan dan Solusi dalam menyiapkan makanan tambahan dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta, serta berbagi pengalaman dapat, mengizinkan peserta untuk berbagi resep atau tips yang mereka ketahui sehingga dapat memperkaya pengetahuan.

Pemberian insentif dan penghargaan diharapkan mampu meningkatkan motivasi peserta dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam pembuatan makanan tambahan bagi balita sehingga dapat mencegah adanya stunting pada balita. Insentif dan penghargaan dapat berupa hadiah kecil seperti memberikan alat memasak atau bahan pangan local sebagai motivasi tambahan dan mendorong peserta untuk terus menerapkan keterampilan yang telah dipelajari. Memberikan sertifikat partisipasi menunjukkan penghargaan terhadap keikutsertaan dan komitmen peserta sehingga meningkatkan motivasi untuk aktif berpartisipasi.

6. Evaluasi

Metode evaluasi efektivitas kelas dapat menggunakan dengan cara:

a. Kuesioner Pra dan Pasca Kelas

Sebelum pemberian materi dan demonstrasi peserta diberikan pra tes untuk menilai seberapa jauh pemahaman peserta dalam materi, kemudian setelah selesai kegiatan *cooking class* peserta diberikan post test. Kembali untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta sebelum dan sesudah mengikuti *cooking class*.

b. Tes Keterampilan

Tes keterampilan diharapkan dapat menilai kemampuan praktis peserta dalam menyiapkan makanan serta memastikan peserta dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari.

c. Observasi Langsung

Observasi langsung dapat dilakukan selama proses memasak berlangsung sehingga dapat mengamati proses memasak dan interaksi peserta selama kelas untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang efektivitas pengajaran.

d. Pengumpulan dan Analisis Data Evaluasi

Penggunaan data untuk menilai pencapaian tujuan kelas, menilai apakah tujuan utama telah tercapai berdasarkan hasil evaluasi yang dikumpulkan. Kemudian identifikasi area yang perlu ditingkatkan, dengan tujuan dapat menemukan aspek yang masih kurang dan membutuhkan perhatian lebih untuk perbaikan kelas berikutnya.

e. Perbaikan Berkelanjutan Berdasarkan Hasil Evaluasi

Menyesuaikan materi atau metode pengajaran sesuai dengan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas kelas. Mengubah pendekatan untuk lebih efektif memenuhi kebutuhan peserta berdasarkan analisis data evaluasi.

D. Peran *Cooking Class* dalam Mencegah Stunting

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini ditandai oleh tinggi badan yang lebih pendek dari standar usia yang ditetapkan, akibat kekurangan gizi kronis selama periode pertumbuhan penting. Stunting tidak hanya mempengaruhi aspek fisik balita tetapi juga perkembangan kognitif dan potensi ekonomi di masa dewasa (World Health Organization, 2020). Untuk mengatasi masalah ini, intervensi gizi yang efektif sangat diperlukan. Salah satu strategi yang dapat diimplementasikan adalah melalui *cooking class* atau kelas memasak yang terfokus pada pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal.

Cooking class dapat memainkan peran penting dalam pencegahan stunting melalui beberapa mekanisme berikut:

1. Peningkatan Pengetahuan Nutrisi

Melalui *cooking class*, peserta, yaitu orang tua, pengasuh, atau kader Kesehatan, dapat memahami pentingnya nutrisi seimbang dan bagaimana memilih serta mengkombinasikan bahan makanan lokal yang kaya akan vitamin dan mineral esensial untuk pertumbuhan balita. Pengetahuan ini memungkinkan peserta untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menyiapkan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi anak.

2. Pengembangan Keterampilan Memasak yang Bergizi

Cooking class mengajarkan teknik memasak yang mempertahankan nilai gizi makanan, seperti mengukus, merebus, dan memanggang. Keterampilan ini memastikan bahwa makanan pendamping yang disiapkan tidak kehilangan nutrisi penting yang diperlukan untuk mencegah stunting. Selain itu, keterampilan ini membantu peserta untuk lebih kreatif dalam mengolah bahan makanan lokal menjadi hidangan yang menarik dan bergizi

3. Pemanfaatan Pangan Lokal yang Kaya Nutrisi
Penggunaan bahan pangan lokal yang tersedia dan bergizi dapat meningkatkan keberagaman dan kualitas makanan pendamping. Pangan lokal sering kali lebih segar dan mengandung lebih banyak nutrisi dibandingkan dengan makanan olahan atau. *Cooking class* dapat mengajarkan peserta cara memanfaatkan berbagai bahan lokal seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, ikan, dan buah-buahan yang kaya akan zat besi, vitamin A, protein, dan kalsium.
4. Mendorong Praktik Pemberian Makanan yang Optimal
Cooking class dapat memberikan panduan tentang waktu dan cara pemberian makanan pendamping yang tepat, serta mengedukasi tentang pentingnya tekstur makanan yang sesuai dengan tahap perkembangan balita. Hal ini membantu memastikan balita mendapatkan asupan gizi yang cukup dan mudah. Praktik pemberian makanan yang tepat juga mencakup pemantauan frekuensi makan dan ukuran porsi yang sesuai dengan kebutuhan anak.
5. Pembentukan Kebiasaan Makan Sehat Sejak Dini
Dengan melibatkan orang tua dalam proses memasak, kelas memasak membantu membentuk kebiasaan makan sehat pada balita. Kebiasaan ini penting untuk mencegah

stunting dan memastikan pertumbuhan serta perkembangan yang optimal. Anak yang terbiasa dengan berbagai jenis makanan sehat sejak dini cenderung memiliki pola makan yang lebih baik dan risiko stunting yang lebih rendah.

Agar *cooking class* efektif dalam pencegahan stunting, beberapa Langkah implementasi berikut dapat diadopsi:

1. Kurikulum Berfokus pada Nutrisi dan Keberagaman Makanan

Kurikulum harus mencakup pendidikan tentang makronutrien dan mikronutrien yang penting untuk pertumbuhan balita, serta cara mengkombinasikan makanan untuk mencapai keseimbangan nutrisi. Materi pembelajaran harus dirancang agar mudah dipahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Penggunaan Resep yang Berbasis Pangan Lokal dan Kaya Nutrisi

Mengembangkan dan mengadaptasi resep yang menggunakan bahan pangan lokal yang kaya akan zat besi, vitamin A, protein, dan kalsium sangat penting. Misalnya, penggunaan sayuran hijau seperti bayam, kacang-kacangan seperti kacang merah, dan ikan lokal seperti ikan teri yang kaya nutrisi dapat meningkatkan kualitas makanan pendamping.

3. Pelatihan Instruktur yang Kompeten

Instruktur harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang gizi anak dan keterampilan memasak yang sesuai untuk memberikan pelatihan yang efektif dan informatif. Selain itu, instruktur harus mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan tingkat pemahaman peserta.

4. Monitoring dan Evaluasi Program

Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas kelas memasak dalam meningkatkan status gizi balita melalui penilaian kesehatan balita sebelum dan sesudah program sangat penting. Monitoring ini dapat dilakukan melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, dan pemeriksaan status gizi anak.

BAB 4

PELATIHAN KADER ANTI STUNTING (PAKEANTING)

A. Pendahuluan

Stunting adalah kondisi tubuh pendek atau sangat pendek berdasarkan tinggi badan menurut usia yang kurang dari 2 standar deviasi kurva pertumbuhan WHO dengan penyebabnya, yaitu asupan nutrisi dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) balita (WHO, 2020). Secara lebih sederhana, stunting merupakan kondisi di mana tinggi badan seorang anak lebih pendek dibandingkan dengan tinggi badan anak lainnya yang seusianya karena kurang asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2017).

Stunting menjadi target dalam Sustainable Development Goals (SDGs), tepatnya pada tujuan pembangunan ke-2, yaitu mengentaskan kelaparan dan menghilangkan segala bentuk malnutrisi (Haskas, 2020). Menurut WHO, stunting termasuk dalam masalah kesehatan masyarakat jika prevalensi melebihi 20% (Kementerian Republik Indonesia, 2016).

Berdasarkan hasil dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan, di mana pada tahun 2021 sebesar 24,4% dan mengalami penurunan menjadi 21,6% pada tahun 2022 (Kemenkes, 2023). Pekalongan termasuk dalam salah satu

kabupaten yang menjadikan stunting sebagai masalah prioritas yang harus ditangani.

Anak dengan kondisi stunting berpotensi mengalami gangguan pada tumbuh kembang, rendahnya kemampuan motorik, dan dapat menderita penyakit tidak menular dengan risiko yang tinggi. Pada masa-masa berikutnya pertumbuhan anak dalam hal fisik maupun kognitif akan terus menurun yang akan berpengaruh pada produktivitas dan pendapatannya di masa dewasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas sumber daya yang menurun, pertumbuhan ekonomi yang terhambat, terciptanya kemiskinan antar generasi, dan makin buruknya kesenjangan adalah dampak jangka panjang dari stunting (Megawati & Wiramihardja, 2019). Oleh karena itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Indonesia menetapkan stunting menjadi isu prioritas nasional dengan target penurunan dari angka 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024 (Kemenkes, 2023).

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang menjadi milik masyarakat dan menyatu dalam kehidupan dan budaya masyarakat. Posyandu berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat serta mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Jumlah Posyandu di Indonesia sebanyak 266.827 yang tersebar di seluruh Indonesia dan terdapat sekitar 3 sampai 4 orang kader per Posyandu dan berarti ada lebih dari 1 juta kader Posyandu. Berdasarkan

data Riskesdas, hampir 78% penimbangan balita dilaksanakan di Posyandu.

Kondisi tersebut memperlihatkan peran penting dari kader Posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat melalui Posyandu. Namun demikian, masih banyak kader yang belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya. Kader Posyandu sebaiknya mampu menjadi pengelola Posyandu dengan baik karena merekalah yang paling memahami kondisi kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Pengelola Posyandu merupakan orang yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu serta kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat. Oleh sebab itu, pelatihan bagi kader Posyandu merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan kader Posyandu khususnya dalam upaya penanganan stunting pada anak.

B. Pemberdayaan kader posyandu

1. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya pembaharuan yang dilakukan untuk mengubah keadaan masyarakat yang awalnya mereka tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan menjadi berdaya. Hal ini dapat dilakukan dengan memfokuskan pada pengembangan potensi dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki kemauan dan kesadaran penuh untuk menentukan masa depannya, dimana pemerintah dan lembaga pemberdayaan hanya sebagai motivator, partisipan, dan sebagainya. Pemberdayaan masyarakat adalah

2. Konsep Posyandu

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memperbanyak dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak (Karwati, dkk, 2010). Posyandu adalah suatu forum komunikasi ahli teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan dan pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Jadi Posyandu adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat atau UKBM yang kegiatannya sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat.

3. Konsep Kader Posyandu

a. Pengertian kader

Menurut WHO, kader kesehatan adalah laki-laki atau perempuan yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah kesehatan perorangan atau masyarakat. Menurut Depkes RI, kader kesehatan adalah perwujudan peran aktif masyarakat dalam pelayanan terpadu. Kader kesehatan juga dapat diartikan sebagai anggota masyarakat yang dipilih oleh dan dari masyarakat, mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan bermasyarakat secara sukarela.

Sasaran utama kegiatan posyandu ini adalah balita dan orang tuanya, ibu hamil, ibu menyusui dan bayinya, serta wanita usia subur. Sedangkan yang

bertindak sebagai pelaksana posyandu adalah kader. Kader adalah seorang tenaga sukarela yang direkrut dari, oleh dan untuk masyarakat, yang bertugas membantu kelancaran pelayanan kesehatan. Keberadaan kader sering dikaitkan dengan pelayanan rutin di posyandu. Sehingga seorang kader posyandu harus mau berkerja secara sukarela dan ikhlas. Mau dan sanggup melaksanakan kegiatan posyandu, serta mau dan sanggup menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan posyandu.

b. Peran kader

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran, jadi peran dapat diartikan suatu konsep diri seseorang berdasarkan perilaku dan status sosial atau kedudukan di masyarakat (Sutiani, 2014)

Peran kader memang sangat penting dalam menjembatani masyarakat khususnya kelompok sasaran posyandu. Berbagai informasi dari pemerintah lebih mudah disampaikan kepada masyarakat melalui kader. Karena kader lebih tanggap dan memiliki pengetahuan kesehatan diatas rata-rata dari kelompok sasaran posyandu (Umar Naim, 2008).

Kader posyandu adalah anggota masyarakat yang diberikan keterampilan untuk menjalankan posyandu (Nurpudji, 2010). Peran kader secara umum adalah melaksanakan kegiatan pelayanan dan mensukseskan bersama masyarakat serta merencanakan kegiatan pelayanan kesehatan tingkat desa.

Peran dan fungsi kader sebagai pelaku penggerakan masyarakat : a) Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). b) Pengamatan terhadap maslaah kesehatan di desa. c) Upaya penyehatan lingkungan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). d) Pemasyarakatan Keluarga sadar gizi (Kadarzi) (Meilani, N. 2009).

Kader posyandu merupakan akses utama bagi para ibu di wilayah puskesmas untuk memperoleh kesehatan yang dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kesadaran diri dan terbatasnya kemampuan untuk mengakses pengetahuan terkait dengan pemenuhan gizi seimbang maupun segala upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Kader memiliki peran untuk meneruskan kembali informasi dan pengetahuan yang didapatkan selama pelatihan maupun sosialisasi kepada ibu balita (Novianti et al., 2021). Pengetahuan dan keaktifan kader dapat memengaruhi perubahan pada perilaku dan pengetahuan ibu mengenai tumbuh kembang anak, khususnya mengenai stunting ke arah yang lebih baik. Menjalankan peran sebagai kader posyandu dalam penurunan stunting membutuhkan bekal pengetahuan dan keterampilan baik ketika memberikan pelayanan, melakukan penimbangan maupun penyuluhan. Keberadaan kader posyandu merupakan suatu yang penting, pelayanan yang diberikan dengan baik dan menarik simpati masyarakat dapat menghasilkan respon positif, menghadirkan rasa kepedulian, serta mendorong partisipasi masyarakat

c. Tugas Kader

Kader kesehatan merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. Mereka adalah individu yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk membantu pelayanan kesehatan dasar di komunitas mereka. Peran kader kesehatan sangat vital, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh tenaga medis profesional.

Kader posyandu adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah kerja Posyandunya. Kader posyandu bertugas di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memantau tumbuh kembang anak. Kader posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah kerja Posyandunya. Kader posyandu bekerja secara sukarela dan melaksanakan kegiatannya setiap bulan.

Sesuai dengan pengertiannya (WHO, 2015) kader bekerja di tempat pemberian pelayanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat, seperti diposyandu. Tugas-tugas kader dalam rangka penyelenggaraan posyandu dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut :

- 1) Tugas Kader pada saat persiapan hari buka posyandu meliputi beberapa hal berikut : a) Menyiapkan alat penimbangan bayi, KMS, alat peraga, serta obat-obatan. b) Mengundang masyarakat untuk datang ke posyandu. c) Menghubungkan kelompok kerja posyandu d)

Melaksanakan pembagian tugas antar kader posyandu.

2) Tugas Kader pada hari buka posyandu

- a) Meja 1 (Pendaftaran): Merupakan layanan pendaftaran, kader melakukan pendaftaran kepada bayi, bayi dan ibu hamil yang datang ke posyandu.
- b) Meja 2 (Penimbangan): Merupakan layanan penimbangan
- c) Meja 3 (Pengisian KMS): Kader melakukan pencatatan pada buku KIA setelah ibu dan balita mendaftar dan ditimbang. Pengisian berat badan kedalam skala yang sesuai dengan umurbayi.
- d) Meja 4 (Penyuluhan): Diketuainya berat batasan anak yang naik atau yang tidak naik, ibu hamil dengan resiko, pasangan usia subur yang belum mengikuti KB, penyuluhan kesehatan, pelayanan IMT, oralit, vitamin A, tablet zat besi pil bulanan, kondom
- e) Meja 5 (Pelayanan): Pemberian makanan tambahan pada bayi dan bayi yang datang ke posyandu, serta penyuntikan imunisasi dilayani dimeja V.

Seorang kader wajib mengikuti penyegaran sebelum menjadi kader posyandu, karena dalam tugasnya akan sering melakukan berbagai penyuluhan. Penyuluhan ini biasanya dilakukan oleh kader posyandu dalam bentuk penyuluhan perorangan dengan tatap muka, penyuluhan kelompok, dan penyuluhan disertai peragaan (demonstrasi). Sehingga kader harus menguasai

berbagai teknik keterampilan dan pengetahuan, yaitu:

a) Keterampilan komunikasi interpersonal.

Keterampilan ini penting karena dalam melaksanakan tugasnya seorang kader perlu memahami kebutuhan masyarakat, serta perlu menguasai teknik-teknik komunikasi yang efektif agar informasi dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat dimengerti dengan baik dan dilaksanakan.

b) Keterampilan yang berhubungan dengan kegiatan di posyandu (pencatatan, pelaporan, penimbangan, dan lain-lain).

Kader perlu memahami system pencatatan dan pelaporan yang benar, agar dapat memperoleh data yang mampu membantu kader mengidentifikasi masyarakat yang perlu dikunjungi dan memperoleh perhatian khusus.

c) Pengetahuan kesehatan dasar dan gizi.

Pemahaman kader yang baik mengenai kesehatan dasar dan gizi dapat membantu kader untuk lebih efektif dalam memberikan informasi dengan benar. Calon kader wajib mengikuti pelatihan-pelatihan sebelum menjadi dan melaksanakan kewajiban sebagai kader posyandu

4. Konsep Pemberdayaan Kader Posyandu

a. Pemberdayaan kader

Pemberdayaan merupakan upaya pembaharuan yang dilakukan untuk mengubah keadaan masyarakat yang awalnya mereka tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan menjadi berdaya.

Hal ini dapat dilakukan dengan memfokuskan pada pengembangan potensi dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki kemauan dan kesadaran penuh untuk menentukan masa depannya, dimana pemerintah dan lembaga pemberdayaan hanya sebagai motivator, partisipan, dan sebagainya. Pemberdayaan kader dilakukan dengan pelatihan kader kesehatan / kader posyandu.

Pelatihan kader kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kader dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dengan pelatihan ini, diharapkan kader kesehatan mampu melakukan deteksi dini penyakit, memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, menyediakan pertolongan pertama pada kasus darurat, dan mengelola program kesehatan masyarakat, seperti posyandu dan program imunisasi.

Pelatihan kader adalah investasi penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, kader kesehatan dapat menjadi mitra yang efektif dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan ini harus terus dilakukan dan ditingkatkan kualitasnya untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang optimal.

Upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan maternal tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan keluarga, tetapi juga komunitas memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, karena petugas kesehatan yang jumlahnya terbatas dan memiliki tanggung jawab yang banyak. Peran

kader yang juga merupakan bagian dari masyarakat karena berasal dari kelompok yang sama dengan masyarakat umum (non petugas kesehatan) bisa menjembatani komunikasi antara petugas kesehatan dan masyarakat khususnya ibu hamil. Bentuk pendekatan kekeluargaan dan komunikasi persuasif antara kader dan masyarakat lebih mudah untuk dilakukan sehingga diharapkan peran kader ini dapat membantu puskesmas dalam penjangkauan kelompok sasaran ibu hamil (maternal) untuk melakukan pelayanan antenatal.

Kader posyandu adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah kerja Posyandunya. Kader posyandu bertugas di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memantau tumbuh kembang anak.

Permasalahan Sumber Daya Manusia tersebut secara tidak langsung mempengaruhi bagaimana pelayanan kesehatan yang ada. Terbukti dengan kurangnya pemahaman para kader Posyandu mengenai stunting yang menyebabkan pelaksanaan pencegahan stunting di Desa mengalami stagnan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bidan Desa, tidak ada sosialisasi terkait penanganan stunting secara konsisten. Mayoritas kader posyandu hanya mengetahui dan melakukan cara mengukur dan menimbang balita, namun tidak dengan pengetahuannya terkait stunting. Sebagian besar tidak mengetahui secara konkret terkait stunting dan pencegahannya.

Upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan maternal tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan keluarga, tetapi juga komunitas memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, karena petugas kesehatan yang jumlahnya terbatas dan memiliki tanggung jawab yang banyak. Peran kader yang juga merupakan bagian dari masyarakat karena berasal dari kelompok yang sama dengan masyarakat umum (non petugas kesehatan) bisa menjembatani komunikasi antara petugas kesehatan dan masyarakat khususnya ibu hamil. Bentuk pendekatan kekeluargaan dan komunikasi persuasif antara kader dan masyarakat lebih mudah untuk dilakukan sehingga diharapkan peran kader ini dapat membantu puskesmas dalam penjangkauan kelompok sasaran ibu hamil (maternal) untuk melakukan pelayanan antenatal.

C. Pelatihan Kader Anti Stunting

1. Pengertian

Pelatihan kader adalah upaya pelaksanaan untuk meningkatkan kualitas kader, seperti pembinaan, pelatihan, penyuluhan dan sebagainya. Dengan terbentuknya kader kesehatan, pelayanan kesehatan yang selama ini dikerjakan oleh petugas kesehatan saja dapat dibantu oleh masyarakat. Dengan demikian masyarakat bukan hanya merupakan objek pembangunan,

tetapi juga merupakan mitra pembangunan itu sendiri. Selanjutnya dengan adanya kader, maka pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan sempurna berkat adanya kader, jelaslah bahwa

pembentukan kader adalah perwujudan pembangunan dalam bidang kesehatan.

Pelatihan kader posyandu merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kader dalam mengembangkan program kesehatan di desa atau kelurahan. Materi pelatihan kader posyandu dapat mencakup:

- a. Posyandu multifungsi
 - b. Cara pengisian buku register posyandu
 - c. Cara pengisian buku Dana Sehat
 - d. Cara pengukuran berat dan tinggi badan bayi dan balita
 - e. Cara pengukuran LILA pada ibu hamil
 - f. Cara pengisian buku KIA
2. Metode pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini bersifat komprehensif dan holistik, melibatkan seluruh aspek dalam pelayanan kebidanan, melibatkan sektor lain dan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat terkait. Metode dimulai dengan melakukan pendekatan kepada Puskesmas, stake holder dan tokoh-tokoh penting di wilayah mitra. Selanjutnya menyusun rencana strategis yang bersifat komprehensif dan terjadwal. Kegiatan yang dilakukan mencakup pelatihan kader tentang materi deteksi dini stunting pada bayi dan balita yang dilaksanakan di masing-masing balai desa dilanjutkan dengan pendampingan praktik di posyandu masing-masing.
 3. Kegiatan selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi yang di ikuti dengan penyusunan rencana tindak lanjut oleh tim bersama dengan mitra. Evaluasi proses kegiatan pengabdian

masyarakat ini akan dilakukan secara bertahap pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan. Evaluasi proses dilaksanakan secara lisan atau tulisan. Evaluasi hasil dilakukan dengan bertanya langsung kepada sasaran kegiatan, serta penyebaran kuisioner untuk menilai kepuasan sasaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam kegiatan ini evaluasi dilakukan dengan pengisian kuesioner posttest dan penilaian saat pendampingan praktik pemeriksaan deteksi dini stunting oleh kader dan edukasi gizi yang dilakukan oleh kader kepada ibu balita yang mengalami stunting dengan menggunakan checklist. Terlihat dari partisipasi aktif yang dilakukan setiap kader dalam mencatat administrasi terkait data ibu dan anak, membantu bidan dalam melakukan pengukuran tinggi badan, lingkaran lengan dan kepala, penimbangan berat badan, pemberian vitamin dan makanan tambahan pada ibu hamil dan balita. Hingga pemeriksaan langsung dari rumah ke rumah terhadap ibu dan balita.

Dalam menangani permasalahan stunting pada balita tentunya membutuhkan penanganan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor. Hal ini sebagaimana dalam Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting bahwa dalam mempercepat turunnya angka stunting, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak untuk bekerja sama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat luas. Posyandu merupakan suatu wadah yang tepat dalam mengoptimalkan 1000 HPK untuk penanganan stunting.

Bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat ini dilakukan untuk memberdayakan dan

memudahkan masyarakat khususnya bagi ibu, bayi, dan balita mendapat pelayanan kesehatan serta pemantauan tumbuh kembangnya. Penggerak utama dari segala kegiatan yang diadakan oleh posyandu adalah kader posyandu (Megawati & Wiramihardja, 2019).

Berdasarkan pernyataan dari Direktorat Bina Gizi, dalam bidang gizi dan kesehatan kader memiliki tugas melakukan pendataan pada balita, menimbang berat badan yang akan dicatat pada Kartu Menuju Sehat, memberikan makanan tambahan, penyuluhan gizi, memberikan vitamin, home visit ke rumah ibu menyusui dan memiliki balita, serta pengukuran tinggi badan sebagai hal yang penting dalam mendeteksi kasus stunting (Megawati & Wiramihardja, 2019). Dengan adanya posyandu, perkembangan status gizi balita dapat erpantau berdasarkan laporan hasil penimbangan tiap bulannya di posyandu oleh kader (Aditya & Purnaweni, 2017).

Kader posyandu memiliki peran sebagai pemberdaya masyarakat. Menurut World Health Organization (WHO), pemberdayaan masyarakat, yaitu proses untuk mengarahkan masyarakat untuk terlibat secara aktif merespon segala permasalahan yang menjadi perhatian, membuat keputusan yang akan berpengaruh pada hidupnya, terlibat dalam perumusan, perencanaan, dan pengimplementasian suatu kebijakan untuk mencapai sebuah perubahan (Burstein & Cabezas, 2016).

Kader posyandu merupakan bagian dari pemberdaya masyarakat karena memiliki kemampuan mendorong masyarakat untuk berkontribusi menghidupkan semangat sosial yang dilakukan dalam bentuk kemampuan menginspirasi, membangun

antusiasme, menstimulasi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk bertindak. Peran kader dalam melakukan semangat sosial ini memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat (Balcazar et al., 2011).

Kader posyandu merupakan anggota masyarakat yang memiliki kesadaran lebih dalam hal meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya ibu dan anak. Layanan kesehatan untuk masyarakat yang memanfaatkan kemampuan dan potensi dari masyarakat merupakan pemberdayaan masyarakat (Alfitri, 2011). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasution, Syahrul Hamidi, dan Sofyan (2020) sejalan dengan penelitian ini di mana peran kader posyandu dalam mencegah dan menangani masalah stunting, yaitu dengan memberikan penyuluhan untuk menyebarluaskan informasi tentang stunting di masyarakat. Selain itu, kader posyandu juga memberikan konseling kesehatan gizi dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pengetahuan ibu yang memiliki balita maupun calon ibu agar adanya perubahan ke arah yang lebih baik.

Peran dengan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang, khususnya faktor perubahan perilaku yang akan memengaruhi peran kader posyandu sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik melalui beberapa indikator yang dikemukakan berdasarkan teori Lawrence Green 2014 (dalam Notoatmodjo, 2014).

a. Pertama, Predisposing factor.

Faktor untuk dapat memberikan kemudahan dan memotivasi baik perorangan maupun kelompok dalam melakukan suatu tindakan.

1) Kader Posyandu Aktif dalam Melakukan Sosialisasi.

Berdasarkan hasil observasi, kader posyandu sangat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada ibu hamil dan balita mengenai pentingnya pencegahan stunting. Bentuk sosialisasi atau pemberian edukasi dilakukan dengan cara yang bervariasi, yaitu melalui lisan, media cetak, dan media digital dengan memanfaatkan sosial media whatsapp. Namun, bentuk pemberian informasi efektif, yaitu dilakukan dengan teknik dari mulut ke mulut (word of mouth) dan atau dengan bantuan media cetak seperti poster informasi kesehatan bergambar. Teknik ini dilakukan karena menyesuaikan dengan karakteristik dari masyarakat pedesaan yang mayoritas belum melek akan perkembangan teknologi sehingga sulit untuk mengakses informasi kesehatan melalui media digital (Prasanti & Fuady, 2018). Sosial media whatsapp dimanfaatkan para kader untuk memberikan informasi terkait jadwal kegiatan posyandu, pemberian vitamin maupun PMT, pemberian vaksin, dan informasi lainnya kepada masyarakat yang memanfaatkan media tersebut. Sekaligus sebagai pengingat bagi perangkat desa, kader posyandu tiap wilayah, dan masyarakat lain untuk saling menyebarluaskan informasi yang diterima secara langsung kepada warga dan tetangga lainnya.

Selain itu, juga dilakukan penyuluhan secara formal dengan mengumpulkan masyarakat terutama ibu hamil maupun balita di Posyandu dengan mengundang ahli gizi dari Puskesmas maupun tenaga ahli lainnya. Pemberian sosialisasi

ini dilakukan dengan media komunikasi yang efektif bagi masyarakat desa dengan kuantitas yang disesuaikan berdasarkan alokasi anggaran yang diberikan aparat desa. Namun, tidak semua kader terbekali dengan baik pengetahuannya tentang informasi yang disampaikan. Sedangkan, seorang kader harus menguasai pengetahuan tentang kesehatan dengan baik khususnya tentang pencegahan stunting agar ketika memberikan penyuluhan kader mampu menyampaikan informasi

- 2) PMT (Pemberian Makanan Tambahan) PMT yang diberikan oleh para kader posyandu berupa PMT Pemulihan dan PMT Penyuluhan yang diperuntukkan bagi balita juga ibu hamil. PMT pemulihan bertujuan untuk pemenuhan gizi balita dan menjadi pembelajaran bagi ibu yang memiliki balita sebagai sasaran, sedangkan PMT penyuluhan makanan tambahan untuk balita yang diberikan oleh kader posyandu (Darubekti, 2021). PMT yang diberikan, yaitu pada setiap kegiatan posyandu dan pemberian PMT wajib sebagai bentuk bantuan makanan dan dalam pencegahan stunting. PMT pemulihan diberikan dalam bentuk susu, telur, dan buah-buahan atau sesuai dengan saran bidan desa maupun ahli gizi yang diperuntukkan selama 90 hari serta jumlah pemberian disesuaikan dengan anggaran desa. PMT penyuluhan diberikan dalam bentuk biskuit juga susu selama adanya penyuluhan atau kegiatan posyandu secara rutin. PMT Pemulihan untuk ibu hamil hanya diperuntukkan bagi ibu hamil yang memang berada dalam kondisi yang membutuhkan atau gizi kurang terpenuhi.

- 3) Pemberian vitamin pada balita dan ibu hamil
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap penyelenggaraan kegiatan posyandu di Desa Sakambang, kader juga berpartisipasi dalam pemberian vitamin pada balita dan ibu hamil serta pemberian imunisasi menjadi salah satu hal wajib dilakukan dan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.
- b. Kedua, Enabling factor. Faktor pemungkin yang berkaitan dengan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan, pemberian kemampuan melalui pelatihan dan bimbingan, pemberian arahan, dan pencarian dana untuk menghadirkan sarana prasarana memadai.
 - 1) Akses Pelayanan ke Posyandu Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan di Desa Sakambang, masih banyak ibu hamil dan orang tua yang memiliki anak balita belum sepenuhnya menghadiri posyandu, selain karena rendahnya motivasi untuk datang hal ini juga disebabkan karena jarak ke posyandu yang jauh dari tempat tinggal masyarakat. Dari permasalahan tersebut, peran kader di Desa Sakambang dibutuhkan untuk home visit ke rumah masyarakat yang memiliki ibu hamil dan anak balita agar mengikuti kegiatan posyandu. Melakukan kunjungan rumah perlu untuk dilakukan meskipun dengan akses yang tidak mudah, untuk memberikan informasi atau edukasi serta memfasilitasi pelayanan pada keluarga terutama keluarga yang berisiko stunting seperti ibu hamil dan menyusui (Lieskusumastuti et al., 2022).

- 2) Fasilitas yang Tersedia untuk Menunjang Kegiatan Posyandu
Posyandu belum memiliki bangunan posyandu secara tetap, artinya kegiatan posyandu dilaksanakan di tempat yang berbeda, seperti di kantor desa, musala, halaman rumah kepala desa maupun halaman rumah warga. Kegiatan posyandu di Desa Sakambang sudah memiliki alat yang lengkap seperti timbangan berat badan, alat pengukur tinggi badan, pengukur lengan, dan lingkaran kepala. Selain itu, kader posyandu juga telah mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan mengenai penggunaan alat-alat tersebut. Peran kader posyandu sangat penting dalam membantu bidan dalam melakukan penimbangan BB, pengukuran TB, pengukuran lingkaran kepala, dan lengan pada balita. Hasil pemeriksaan tersebut akan diverifikasi kembali setiap bulan Februari dan Agustus untuk mendeteksi adanya kasus stunting. Dalam meningkatkan keterampilan dan kapasitasnya, kader posyandu mendapatkan pelatihan dan bimbingan dari tenaga kesehatan yang ada di puskesmas
- c. Ketiga, Reinforcing Factor. Faktor penguat yang berkaitan dengan sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, dan petugas khususnya petugas kesehatan dengan tujuan agar sikap dari mereka dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal hidup berperilaku hidup sehat. Dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Dukungan Pemerintah terhadap Kegiatan Posyandu dalam Pencegahan Stunting Faktor penguat dalam terlaksananya kegiatan posyandu yang terkait

dengan pencegahan stunting, yaitu adanya alokasi dana khusus stunting yang dikeluarkan aparat Desa Sakambang. Dana yang telah diberikan kemudian dikelola untuk pendistribusian PMT penyuluhan dan PMT pemulihan, pengadaan obat dan vitamin, operasional pelayanan posyandu, bidan desa, serta pengadaan sosialisasi stunting. Dana yang ada cukup membantu dalam mengoptimalkan segala kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan stunting. Menganggarkan dana desa untuk pencegahan stunting merupakan kewajiban Pemerintah Desa, hal ini karena stunting merupakan program prioritas nasional sekaligus mendukung tercapainya SDG's Desa khususnya pada poin Desa tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan, desa sehat sejahtera, dan Desa berenergi bersih dan terbarukan (Erowati, 2021). Selain itu, Kementerian Desa memberikan ketentuan bahwa Desa yang tidak menganggarkan dana untuk pencegahan stunting, maka anggaran dana desa yang diterima akan dikurangi atau dipotong pada tahun selanjutnya (Friska & Andriani, 2022).

- 2) Dukungan Ibu Balita terhadap Kegiatan Posyandu dalam Pencegahan Stunting Bentuk partisipasi ibu balita dapat terlihat dengan mayoritas ibu balita memiliki antusiasme untuk datang ke posyandu rutin maupun acara penyuluhan. Hal ini bentuk dampak positif pengetahuan yang telah diberikan mengenai pentingnya kegiatan posyandu kepada masyarakat. Namun, ada pula ibu balita yang pasif dalam mengikuti kegiatan dari posyandu sehingga harus dilakukan kunjungan secara langsung ke

rumah (door to door) balita tersebut untuk dilakukan pengukuran dan penimbangan maupun penyuluhan terkait kesehatan ibu maupun balita. Salah satu hal yang menjadi penghambat peran kader posyandu dalam pencegahan stunting di lapangan, yaitu dari ibu balita itu sendiri yang minim pengetahuan tentang pentingnya penyuluhan maupun konseling gizi karena pemahaman yang berbeda sehingga berpengaruh dalam penyerapan informasi yang diberikan (Novianti et al., 2021). Dukungan Petugas Kesehatan terhadap Kegiatan Posyandu dalam Pencegahan Stunting Peran petugas kesehatan dalam misi pencegahan stunting dilakukan dengan gabungan antara dokter umum, ahli gizi, bidan desa, dan lainnya. Puskesmas sebagai wadah utama pelaksanaan posyandu dengan membentuk kader kader di setiap pos posyandu untuk melaksanakan penyuluhan bersama bidan desa terkait kesehatan ibu hamil dan balita stunting. Ketika menjalankan perannya, kader akan diberikan pengetahuan maupun keterampilan dasar melalui penyuluhan dan pelatihan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Tanpa adanya edukasi dari petugas kesehatan, kegiatan pencegahan stunting di Posyandu tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini karena dalam menjalankan tugas kader posyandu membutuhkan pengetahuan dasar mengenai stunting, kesehatan ibu hamil dan balita, serta pendataan dari kegiatan posyandu. Pelatihan dan pendampingan oleh tenaga kesehatan profesional yang fokus pada pencegahan stunting akan membuat kader mampu

menjalankan perannya dengan terampil dalam hal penyuluhan kesehatan dan gizi mulai dari masa kehamilan hingga memonitoring status balita stunting (Ngaisyah & Adiputra, 2018).

BAB 5

PENUTUP

Dalam perjalanan penyusunan monograf ini, *"Optimalisasi Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal, Cooking Class dan Pelatihan Kader terhadap Peningkatan Kesehatan dan Kebugaran Balita,"* kami telah mengeksplorasi berbagai aspek penting yang saling berkaitan dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan balita melalui pemberian makanan tambahan yang optimal. Fokus utama dari penelitian ini adalah pemanfaatan pangan lokal, implementasi kelas memasak sebagai media edukasi, serta pelatihan kader kesehatan sebagai ujung tombak program kesehatan masyarakat. Monograf ini tidak hanya menyajikan teori dan praktik yang mendalam tetapi juga memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan program yang berkelanjutan dan efektif di masa depan.

Pemberian makanan tambahan yang tepat merupakan salah satu faktor krusial dalam mencegah malnutrisi dan stunting pada balita. Stunting, yang ditandai oleh tinggi badan yang lebih pendek dari standar usia, merupakan indikator serius dari kegagalan pertumbuhan yang tidak hanya berdampak pada aspek fisik tetapi juga kognitif dan potensi ekonomi anak di masa depan. Kondisi ini diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis selama periode kritis pertumbuhan, khususnya selama 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga usia dua tahun. Oleh karena itu, intervensi yang tepat dan efektif dalam pemberian makanan tambahan sangat diperlukan untuk mencegah dan mengatasi masalah stunting ini.

Penggunaan pangan lokal sebagai dasar pemberian makanan tambahan menawarkan banyak keuntungan yang signifikan. Pangan lokal yang tersedia secara melimpah di komunitas setempat sering kali lebih segar dan kaya akan nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral yang esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan balita. Selain itu, penggunaan pangan lokal juga mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di tingkat komunitas. Dengan meningkatkan permintaan terhadap produk lokal, kita dapat mendorong peningkatan produksi dan kualitas bahan pangan lokal, serta mendukung petani dan produsen lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan bahan makanan yang bergizi tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bahan makanan impor yang sering kali lebih mahal dan kurang bergizi.

Kelas memasak atau *cooking class* memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pemberian makanan tambahan bagi balita. Melalui kelas memasak, orang tua, pengasuh, dan kader kesehatan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis dalam menyiapkan makanan yang tidak hanya lezat tetapi juga bergizi dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan balita. Kelas memasak mengajarkan teknik-teknik memasak yang mempertahankan nilai gizi makanan, seperti mengukus, merebus, dan memanggang. Teknik ini penting untuk memastikan bahwa makanan pendamping yang disiapkan tidak kehilangan nutrisi penting selama proses memasak. Selain itu, kelas memasak mendorong penggunaan bahan pangan lokal yang tersedia dan kaya nutrisi, seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, ikan, dan buah-buahan yang memiliki kandungan vitamin dan mineral esensial.

Selain peningkatan pengetahuan dan keterampilan memasak, kelas memasak juga berkontribusi dalam

pembentukan kebiasaan makan sehat sejak dini. Dengan melibatkan orang tua dalam proses memasak, balita terbiasa dengan berbagai jenis makanan sehat yang bervariasi, yang pada gilirannya mengurangi risiko mereka menjadi picky eaters atau memiliki kebiasaan makan yang buruk. Anak-anak yang terbiasa dengan makanan sehat sejak dini cenderung memiliki pola makan yang lebih baik dan risiko stunting yang lebih rendah. Selain itu, kreativitas dalam mengolah bahan makanan lokal juga dapat meningkatkan variasi menu yang menarik bagi balita, memastikan bahwa mereka mendapatkan asupan nutrisi yang beragam dan seimbang.

Pelatihan kader kesehatan adalah elemen kunci lainnya dalam memastikan keberhasilan program pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal. Kader kesehatan berfungsi sebagai penghubung yang efektif antara masyarakat dan program kesehatan pemerintah atau organisasi non-pemerintah. Mereka bertugas menyampaikan informasi mengenai pentingnya pemberian makanan tambahan yang bergizi dan bagaimana cara mengimplementasikannya di rumah. Selain itu, kader kesehatan juga bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap status gizi balita di komunitas mereka, memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan.

Sinergi antara penggunaan pangan lokal, implementasi kelas memasak, dan pelatihan kader kesehatan menciptakan sebuah ekosistem yang mendukung optimalisasi pemberian makanan tambahan bagi balita. Ketiga elemen ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan balita. Penggunaan pangan lokal menyediakan sumber bahan makanan yang segar dan bergizi, kelas memasak

menyediakan edukasi praktis dan keterampilan yang diperlukan untuk menyiapkan makanan tersebut, dan pelatihan kader kesehatan memastikan bahwa program ini dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan di tingkat komunitas.

Namun, implementasi program ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya, seperti dana, peralatan memasak, dan akses ke bahan pangan lokal, dapat menghambat pelaksanaan program. Partisipasi rendah dari orang tua dan pengasuh juga menjadi kendala utama yang perlu diatasi. Selain itu, kultur dan kebiasaan makan tradisional yang tidak selalu sejalan dengan prinsip nutrisi modern dapat menjadi hambatan dalam penerapan program ini. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, termasuk penggalangan dana, promosi dan penyuluhan yang lebih intensif, serta pengembangan kemitraan dengan petani dan pemasok lokal untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang konsisten dan berkualitas.

Rekomendasi strategis yang diusulkan dalam monograf ini meliputi integrasi program pemberian makanan tambahan dengan program kesehatan masyarakat lainnya, seperti imunisasi dan pemeriksaan gizi rutin. Penggunaan teknologi modern seperti aplikasi resep digital dan platform pembelajaran online juga direkomendasikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas kelas memasak. Pelatihan berkelanjutan bagi instruktur dan kader kesehatan diperlukan untuk memastikan mereka selalu update dengan pengetahuan dan teknik terbaru dalam gizi dan memasak. Selain itu, pemberdayaan komunitas melalui partisipasi aktif dalam setiap tahap implementasi program dapat meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan program.

Impikasi dari implementasi program pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, kelas memasak, dan pelatihan kader kesehatan sangat luas dan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan komunitas. Peningkatan status gizi dan kesehatan balita adalah dampak langsung yang dapat diukur dari program ini, namun dampak jangka panjang yang lebih luas mencakup penguatan ekonomi lokal, peningkatan kesadaran dan edukasi gizi di masyarakat, dukungan terhadap keberlanjutan lingkungan, dan pembentukan komunitas yang mandiri dan berdaya. Semua ini berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sehat, mandiri, dan berdaya, di mana setiap balita tumbuh dengan sehat dan berkembang secara optimal.

Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari peningkatan status gizi balita tetapi juga dari dampak positif yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi lokal, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan mengatasi berbagai tantangan melalui pendekatan yang inovatif dan kolaboratif, program pemberian makanan tambahan ini dapat menjadi model yang dapat direplikasi di berbagai komunitas lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lokal sangat penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program ini.

Akhir kata, optimalisasi pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, kelas memasak, dan pelatihan kader kesehatan merupakan strategi yang komprehensif dan holistik dalam meningkatkan kesehatan dan kebugaran balita. Melalui sinergi antara penggunaan pangan lokal, edukasi praktis melalui kelas memasak, dan dukungan dari kader kesehatan yang terlatih, program ini mampu menghadirkan solusi yang efektif dalam mencegah stunting dan malnutrisi pada anak-anak.

Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari peningkatan status gizi balita tetapi juga dari dampak positif yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi lokal, dan keberlanjutan lingkungan.

Monograf ini berharap dapat menjadi sumber informasi dan panduan praktis bagi para profesional kesehatan, pengasuh, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kebugaran balita melalui pemberian makanan tambahan yang optimal. Dengan mengintegrasikan pangan lokal, kelas memasak, dan pelatihan kader kesehatan, kita dapat menciptakan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam masyarakat, memastikan setiap balita tumbuh dengan sehat dan berkembang secara optimal. Melalui komitmen dan kerja keras bersama, kita dapat mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berdaya, di mana setiap balita mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Rekomendasi Akhir

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi strategis diusulkan untuk pengembangan dan peningkatan program pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, kelas memasak, dan pelatihan kader kesehatan di masa depan. Pertama, pengembangan kebijakan yang mendukung sangat penting. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung penggunaan pangan lokal dalam program pemberian makanan tambahan, termasuk insentif bagi petani lokal dan penyediaan bahan pangan yang terjangkau. Kebijakan ini akan mendorong penggunaan pangan lokal secara lebih luas dan memastikan keberlanjutan program.

Kedua, investasi dalam infrastruktur dan sumber daya juga diperlukan. Investasi yang cukup dalam infrastruktur dapur,

peralatan memasak, dan akses ke bahan pangan lokal sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kelas memasak yang efektif. Selain itu, penyediaan dana yang memadai akan memastikan bahwa program dapat berjalan tanpa hambatan dan dapat menjangkau lebih banyak peserta.

Ketiga, peningkatan kapasitas dan keterampilan kader kesehatan adalah elemen kunci yang tidak boleh diabaikan. Pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas kader kesehatan diperlukan untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan program pemberian makanan tambahan. Program sertifikasi atau pendidikan tambahan dapat meningkatkan kompetensi kader dalam menjalankan tugas mereka, sehingga program dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Keempat, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat dianjurkan. Kolaborasi yang erat dengan sektor swasta dan LSM dapat menyediakan sumber daya tambahan, inovasi, dan dukungan teknis yang diperlukan untuk memperluas dan memperdalam dampak program. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui pendanaan, penyediaan peralatan, atau bahkan melalui inovasi dalam penyusunan resep dan teknik memasak. LSM, di sisi lain, sering kali memiliki jaringan dan pengalaman dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas program.

Kelima, monitoring dan evaluasi yang sistematis adalah langkah penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Penggunaan indikator kesehatan yang relevan

seperti peningkatan berat badan, tinggi badan, dan penurunan angka stunting dapat menjadi tolok ukur keberhasilan program. Data yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki program secara berkelanjutan dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan yang berubah.

Keenam, pemberdayaan komunitas melalui partisipasi aktif merupakan rekomendasi penting. Mendorong partisipasi aktif dari komunitas dalam setiap tahap implementasi program dapat meningkatkan rasa memiliki dan memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Melibatkan anggota komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program akan meningkatkan keberlanjutan program dan memastikan bahwa program tersebut relevan dan diterima oleh masyarakat setempat.

Ketujuh, pengembangan resep yang inovatif dan berkelanjutan harus terus dilakukan. Mengembangkan resep yang inovatif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai macam bahan pangan lokal dapat meningkatkan keberagaman dan kualitas makanan pendamping balita. Resep harus disesuaikan dengan ketersediaan musiman dan preferensi rasa masyarakat setempat untuk memastikan penerimaan yang tinggi. Inovasi dalam pengembangan resep juga dapat mencakup penggunaan bahan-bahan yang kaya nutrisi dan rendah biaya, sehingga makanan tambahan dapat diakses oleh lebih banyak keluarga.

Kedelapan, penggunaan teknologi digital sebagai pendukung pembelajaran sangat dianjurkan. Integrasi teknologi digital seperti aplikasi resep, platform pembelajaran online, dan media sosial dapat meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas kelas memasak. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk memfasilitasi interaksi dan berbagi informasi antar

peserta, memperkuat jaringan komunitas, dan menyediakan sumber daya tambahan yang dapat diakses kapan saja. Penggunaan teknologi ini akan memungkinkan program untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memastikan bahwa peserta dapat terus belajar dan berinteraksi meskipun tidak berada di lokasi fisik kelas memasak.

Kesembilan, peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pemberian makanan tambahan yang bergizi sangat penting. Melalui kampanye kesehatan dan edukasi publik, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemberian makanan tambahan yang bergizi dan peran keluarga dalam menjaga kesehatan balita akan memperkuat dampak program. Edukasi ini harus mencakup informasi tentang manfaat nutrisi, teknik memasak sehat, dan pentingnya penggunaan pangan lokal dalam diet balita. Edukasi yang efektif akan membantu mengubah pola makan dan kebiasaan konsumsi masyarakat secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan balita.

Terakhir, fokus pada keberlanjutan lingkungan harus menjadi bagian integral dari setiap program pemberian makanan tambahan. Program harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, termasuk penggunaan bahan pangan yang ramah lingkungan dan pengurangan limbah dapur. Praktik ramah lingkungan tidak hanya mendukung kesehatan balita tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Dengan mengurangi ketergantungan pada bahan pangan impor yang sering kali memiliki dampak lingkungan yang besar, program ini juga berkontribusi pada pengurangan jejak karbon dan peningkatan ketahanan pangan lokal.

Implikasi terhadap Kesehatan Masyarakat dan Keberlanjutan Komunitas

Implementasi program pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, kelas memasak, dan pelatihan kader kesehatan memiliki implikasi yang luas terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan komunitas. Peningkatan status gizi dan kesehatan balita adalah dampak langsung yang dapat diukur dari program ini. Balita yang mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang akan tumbuh dengan sehat dan memiliki perkembangan kognitif yang optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup mereka dan potensi ekonomi di masa depan.

Penggunaan pangan lokal dalam program ini juga memiliki dampak positif pada ekonomi lokal. Dengan meningkatkan permintaan terhadap produk lokal, program ini mendukung petani dan produsen lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mendorong peningkatan kualitas produk. Hal ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan bahan makanan yang bergizi tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi komunitas, memastikan bahwa program ini dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain itu, peningkatan kesadaran dan edukasi gizi di masyarakat melalui program ini akan menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya nutrisi seimbang dan teknik memasak yang sehat. Orang tua dan pengasuh yang lebih sadar akan pentingnya nutrisi akan lebih mampu membuat keputusan yang tepat dalam pemberian makanan tambahan kepada balita mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan balita.

Program ini juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan melalui penggunaan pangan lokal dan praktik memasak yang ramah lingkungan. Dengan mengurangi

ketergantungan pada bahan pangan impor yang sering kali memiliki dampak lingkungan yang besar, program ini membantu mengurangi jejak karbon dan mendukung praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, pengurangan limbah dapur dan penggunaan bahan pangan yang berkelanjutan juga mendukung upaya pelestarian lingkungan, memastikan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan balita tetapi juga bagi keberlanjutan lingkungan.

Pelatihan kader kesehatan yang terintegrasi dalam program ini juga membentuk komunitas yang lebih mandiri dan berdaya. Kader kesehatan yang terlatih tidak hanya dapat menjalankan program pemberian makanan tambahan tetapi juga dapat menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka, menyebarkan informasi dan edukasi tentang pentingnya nutrisi seimbang dan pemberian makanan tambahan yang optimal. Pembentukan komunitas yang lebih mandiri dan berdaya ini akan memastikan bahwa program ini dapat terus berjalan dan berkembang meskipun tanpa dukungan eksternal yang terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, Ambar Sari, D., Ihromi, S., Nurhayati, Pacitra, S., Danela Luthfiah, T., & Rizal, H. (2021). Cegah Stunting Dan Gizi Buruk Pada Balita Dengan Edukasi Gizi Bagi Tumbuh Kembang Anak Di Desa Banyumulek Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat (JADM)*, 2(2), 7–12. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jadm>
- Kemenkes RI. (2010). Buku Pegangan Kader Pendamping Keluarga Menuju Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi). Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2011). Panduan Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Bagi Balita Gizi Kurang. Jakarta : Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Dan Anak.
- Kemenkes RI. (2017). Panduan Pelaksanaan Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas (GENTAS). Jakarta : Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI.
- KEMENKES RI. (2018). Bahan Ajar : Konseling Gizi. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KEMENKES RI. (2018). Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. Jakarta : Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI.
- PARAMITHA, I. A., ARIFIANA, R. ., PANGESTU, G. K. ., RAHAYU, N. A. ., & ROSIDI, A. . (2024). GAMBARAN KEJADIAN

STUNTING BERDASARKAN KARAKTERISTIK IBU PADA
BALITA USIA 24-59 BULAN . *HEALTHY : Jurnal Inovasi
Riset Ilmu Kesehatan*, 3(1), 37-44.
<https://doi.org/10.51878/healthy.v3i1.2736>

Paramitha, I. A., Saputri, H. D., & Puspa, M. (2022). Analysis of Knowledge towards Mother's Behavior in Choosing Food Menus to Support Toddler Fitness in the Covid-19 Pandemic. Proceeding of The URECOL, 232-238.
<http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1938>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia.

Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil Bahan Pangan Lokal dan Pabrik, Kementerian Kesehatan, 2015.

Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan, Kementerian Kesehatan, 2017.

Permenkes no 17 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemkes RI

Rosidi, A., Yuliyanti, S. ., Sari, A. S. ., Paramitha, I. A. ., & Syukri, M. (2023). Pengetahuan Ibu Berhubungan dengan Perkembangan Motorik Kasar pada Anak Usia 12-24 Bulan. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 13(2), 683-690.
<https://doi.org/10.32583/pskm.v13i2.872>

GLOSARIUM

A

Asam Folat: Asam folat adalah bentuk vitamin B9 yang berperan penting dalam produksi sel darah merah dan membantu perkembangan otak dan sumsum tulang belakang pada bayi yang dibutuhkan ibu hamil

K

KEK: adalah Kekurangan Energi Kronis (KEK) merupakan keadaan dimana seseorang menderita ketidak seimbangan asupan gizi (energi dan protein) yang berlangsung menahun. Status Kekurangan Energi Kronis (KEK) sebelum kehamilan dalam jangka panjang dan selama kehamilan akan menyebabkan ibu melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah.

L

LILA: adalah Ibu Hamil yang memiliki risiko KEK yaitu yang mempunyai ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) di bawah 23,5 cm atau Indeks Massa Tubuh (IMT) pada pra hamil atau Trimester I (usia kehamilan ≤ 12 minggu) dibawah 18,5 kg/m² (Kurus)

M

MPASI: adalah singkatan dari Makanan Pendamping ASI, yaitu makanan yang diberikan kepada bayi setelah berusia 6 bulan atau lebih sebagai pelengkap ASI

P

PMT: adalah program yang memberikan makanan kepada balita untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Tujuannya agar anak

dapat mencapai berat badan yang sesuai dengan usianya dan mencegah stunting.

PROFIL PENULIS



Bdn. Intan Azkia Paramitha, S.Tr.Keb., M.Keb lahir di Padang Hangat tanggal 09 Mei 1995. Penulis berasal dari Provinsi Bengkulu, dan beralamat di Lenek Pasiraman, Lombok Timur kemudian saat ini berdomisili di Pekalongan Jawa Tengah. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Telah menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan di Stikes Tri Mandiri Sakti Bengkulu, lanjut DIV Kebidanan di Universitas Indonesia Maju Jakarta kemudian melanjutkan S2 Ilmu Kebidanan dan Profesi Bidan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Penulis menekuni bidang menulis, dengan menerbitkan artikel dibidang kesehatan khususnya kebidanan, kemudian juga pernah menulis book chapter yang berjudul Aktivitas Fisik Penunjang Kebugaran pada Wanita, Cegah Stunting melalui pola makan, pola asuh dan sanitasi. Penulis banyak meneliti tentang balita, terutama gizi bagi balita stunting. Penulis pernah meng-Haki kan buku Menu harian berbahan lokal bagi balita stunting, serta penelitian mengenai PMT bagi balita stunting yang menggunakan bahan-bahan lokal. Adapun email penulis intanazkia09@gmail.com

Motto: "Doakan, Ikhtiarkan, dan Ikhlasikan. Allah perencana Terbaik".

PROFIL PENULIS



Ratna Arifiana, SST., M.K.M. lahir di Pekalongan pada tanggal 13 Januari 1992. Penulis berasal dari provinsi Jawa Tengah dan berdomisili di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bida, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Telah menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan di STIKES Muhammadiyah Pekajangan, lanjut DIV Bidan Pendidik di Universitas Sebelas Maret, kemudian Melanjutkan studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Kesehatan Ibu dan Anak di Universitas Sebelas Maret. Pengalaman penulis dalam menulis *Book Chapter* dengan judul Aktivitas Fisik Penunjang Kebugaran pada Wanita.

Email: arifianaratna1301@gmail.com

PROFIL PENULIS

Sandi Ari Susiatmi, lahir di Pekalongan 24 Januari 1988. Jenjang Pendidikan Diploma 4 Kebidanan ditempuh di Universitas Aisyiyah Yogyakarta lulus tahun 2010. Pendidikan S2 Kebidanan, lulus tahun 2017 di Universitas Padjajaran Bandung serta profesi bidan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta lulus tahun 2023. Terlibat dalam beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat tentang bayi balita dan anak prasekolah Saat ini menjabat sebagai Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Muhamamdiyah Pekajangan Pekalongan Prodi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan dan mengampu matakuliah Asuhan Bayi Balita dan Anak Prasekolah. Penulis aktif sebagai Pengurus Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Pekalongan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, sebagai Bidan Delima dan membuka Praktik Mandiri Bidan.

SINOPSIS BUKU

Buku monograf ***"Merdeka dari Stunting: Optimalisasi Pemberian Makanan Tambahan berbasis Pangan Lokal, Cooking Class, dan Pelatihan Kader terhadap Peningkatan Kesehatan dan Kebugaran Balita"*** merupakan panduan komprehensif yang menyajikan pendekatan multidimensi dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia. Mengacu pada data prevalensi stunting yang masih tinggi, buku ini menawarkan solusi berbasis komunitas dengan memanfaatkan potensi pangan lokal sebagai kunci utama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.

Buku ini diawali dengan penjelasan mendalam tentang tantangan stunting di Indonesia, mencakup penyebab utama, dampak jangka panjang, serta urgensi untuk segera mengambil langkah intervensi. Dengan menyadari bahwa stunting adalah isu multidimensional, buku ini menyoroti pentingnya sinergi antara pemberian makanan tambahan (PMT), pendidikan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan utama yang diusulkan melibatkan tiga pilar:

1. **Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal:** Pemanfaatan bahan makanan lokal yang kaya gizi, mudah diakses, dan terjangkau oleh masyarakat menjadi inti dari intervensi ini. Buku ini memberikan contoh resep dan cara pengolahan yang dapat langsung diterapkan oleh keluarga.
2. ***Cooking Class* untuk Masyarakat:** Melalui kegiatan pelatihan memasak, keluarga dan masyarakat dilatih untuk mengolah bahan pangan lokal menjadi menu sehat yang disukai anak-anak. Kegiatan ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi dalam pertumbuhan anak.

3. **Pelatihan Kader Posyandu:** Kader posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung program ini. Buku ini menjelaskan bagaimana pelatihan kader dapat memperkuat implementasi program secara berkelanjutan.

Buku ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi akademisi, praktisi kesehatan, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas yang peduli terhadap masa depan generasi bangsa. *"Merdeka dari Stunting"* bukan hanya sebuah buku, tetapi sebuah gerakan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari stunting dan menciptakan generasi emas yang sehat, Bugar dan cerdas.

Buku monograf "Merdeka dari Stunting: Optimalisasi Pemberian Makanan Tambahan berbasis Pangan Lokal, Cooking Class, dan Pelatihan Kader terhadap Peningkatan Kesehatan dan Kebugaran Balita" merupakan panduan komprehensif yang menyajikan pendekatan multidimensi dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia. Mengacu pada data prevalensi stunting yang masih tinggi, buku ini menawarkan solusi berbasis komunitas dengan memanfaatkan potensi pangan lokal sebagai kunci utama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.

Buku ini diawali dengan penjelasan mendalam tentang tantangan stunting di Indonesia, mencakup penyebab utama, dampak jangka panjang, serta urgensi untuk segera mengambil langkah intervensi. Dengan menyadari bahwa stunting adalah isu multidimensional, buku ini menyoroti pentingnya sinergi antara pemberian makanan tambahan (PMT), pendidikan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan utama yang diusulkan melibatkan tiga pilar:

1. Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal: Pemanfaatan bahan makanan lokal yang kaya gizi, mudah diakses, dan terjangkau oleh masyarakat menjadi inti dari intervensi ini. Buku ini memberikan contoh resep dan cara pengolahan yang dapat langsung diterapkan oleh keluarga.

2. Cooking Class untuk Masyarakat: Melalui kegiatan pelatihan memasak, keluarga dan masyarakat dilatih untuk mengolah bahan pangan lokal menjadi menu sehat yang disukai anak-anak. Kegiatan ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi dalam pertumbuhan anak.

3. Pelatihan Kader Posyandu: Kader posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung program ini. Buku ini menjelaskan bagaimana pelatihan kader dapat memperkuat implementasi program secara berkelanjutan.

Buku ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi akademisi, praktisi kesehatan, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas yang peduli terhadap masa depan generasi bangsa. "Merdeka dari Stunting" bukan hanya sebuah buku, tetapi sebuah gerakan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari stunting dan menciptakan generasi emas yang sehat, Bugar dan cerdas.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

